



R

ecomendaciones generales para mejorar la calidad en la Atención Obstétrica

RECOMENDACIONES GENERALES PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA

Recomendaciones generales para mejorar la calidad en la
atención obstétrica

ISBN 970-721-220-9 (Original 2003)
ISBN en trámite

Comisión Nacional de Arbitraje Médico
CONAMED

Mitla 250 esquina Eugenia
Col. Vértiz-Narvarte, C. P. 03020,
México, D. F.

Lada sin costo: 01 800 711 06 58
En el Distrito Federal: 5420 7000

recomendaciones@conamed.gob.mx

Primera Edición: L.D. G. Mónica Sánchez Blanco
Actualización: Lic. Gloria Flores Romero

RECOMENDACIONES GENERALES PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA

COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

**RECOMENDACIONES GENERALES
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA**

DIRECTORIO

Dr. José Meljem Moctezuma
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico

Dr. Javier Rodríguez Suárez
Director General de Difusión e Investigación

Dr. Luis Alberto Villanueva Egan
Director de Investigación

Dra. Esther Mahuina Campos Castolo
Subdirectora de Investigación

GRUPO DE TRABAJO DE LA ACTUALIZACIÓN 2012

Dra. Esther Mahuina Campos Castolo
Dr. Luis Alberto Villanueva Egan
PSSD. Isabel González García
LEO. Cynthia Ramírez Hernández
Lic. Gloria Flores Romero

GRUPO DE TRABAJO DE LA PRIMERA EDICIÓN (2003)

Dra. Esther Mahuina Campos Castolo
Acad. Dr. José Roberto Ahued Ahued
Dr. Alberto Smeke Darwich
Dr. Salvador Casares Queralt
Dr. Jorge Sánchez González
Dra. Judith Ablanedo Aguirre
Dr. Enrique Aguilera Beteta
Dr. Sergio Fajardo Dueñas

Dr. Carlos Fernández del Castillo
Dr. Ricardo García Cavazos
Dr. Mario E. Guzmán Huerta
Dr. José Antonio Ruíz Moreno
Dr. Rubén Tlapanco Barba
Dr. Drusso Vera Gaspar
Dr. Carlos Hinojosa y Ríos (Q.E.P.D.)
Dr. Victoriano Llaca Rodríguez Q.E.P.D.)

PRIMERA EDICIÓN MARZO DE 2003
ACTUALIZACIÓN OCTUBRE DE 2012

RECOMENDACIONES GENERALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En el célebre tratado de Williams se describe a la Obstetricia desde una perspectiva amplia, como la “disciplina que se relaciona con la reproducción de una nación, porque se ocupa de todos los factores fisiológicos, patológicos, psicológicos y sociales que influyen profundamente tanto en la cantidad como en la calidad de las nuevas generaciones de ciudadanos”. La acepción más comúnmente utilizada es como la parte de la medicina que se ocupa de la mujer durante el embarazo, el trabajo de parto y el puerperio, tanto en circunstancias normales como anómalas.¹⁻³

Los cuidados perinatales otorgados por los obstetras, incluyen la vigilancia prenatal y la asistencia intraparto y tienen como objetivo conseguir que todo embarazo y parto culminen con una madre y un hijo sanos. La evaluación de la calidad y eficacia de los cuidados perinatales es una preocupación y un objetivo de cualquier institución, hospital, región o país.² De esta evaluación se puede deducir la idoneidad de los cuidados sanitarios y de las estrategias diagnósticas y terapéuticas adoptadas, así como las posibles deficiencias y limitaciones.

A partir del siglo XX comenzó un proceso de “medicalización”, caracterizado por la sustitución de la partera por el médico y del hogar por el hospital durante los partos eutócicos y acompañado de una serie de prácticas que caracterizan la obstetricia moderna. Sin embargo, muchas de ellas no han demostrado su beneficio para el binomio y en otros casos, inclusive, se ha evidenciado su papel perjudicial.⁴

La Ginecología y Obstetricia es una de las especialidades con mayor número de quejas en la estadística de CONAMED y de algunas Comisiones Estatales de Arbitraje Médico. Durante el periodo 2003-2007, alcanzó el nada honroso primer lugar, demostrándose además como la especialidad más relacionada a daño permanente o muerte, cuando se asocia con mala práctica.⁵⁻⁶

Se puede explicar la alta frecuencia de inconformidades y eventos adversos de manera proporcional, ya que la atención materna representa aproximadamente la mitad de las intervenciones médicas que se realizan en nuestro país. En el año 2008, los egresos de la especialidad de ginecología y obstetricia representaron el 39.4% del total, mientras que en 2011, correspondieron a causas obstétricas (CIE O) el 45.2% de los egresos hospitalarios.⁷⁻⁸ En las estadísticas del 2008, los procedimientos obstétricos (cesárea, episiorrafia, legrado uterino instrumental, revisión de cavidad postalumbramiento, aplicación de fórceps) y la atención del trabajo de parto representaron 11% del total de urgencias.⁹

Aunque estas cifras expliquen la importancia numérica de la atención obstétrica en nuestro país,

la trascendencia epidemiológica y social de la morbilidad y mortalidad materna e infantil, establecen su muy importante valor como eventos centinelas e indicadores indirectos de la calidad de atención obstétrica, de las condiciones de salud de una población y del estado de desarrollo de una nación.¹⁰⁻¹²

Con el espíritu de contribuir a la tradición mexicana de cuidados prenatales exitosos y el compromiso de retroalimentar al Sistema Nacional de Salud, se ha reunido a un grupo de prestigiados ginecoobstetras líderes de opinión, para analizar la experiencia de la CONAMED con relación a conflictos derivados de atención obstétrica y expresar recomendaciones que permitan al gremio ejercer una obstetricia de extraordinaria calidad y satisfacción para las gestantes y los especialistas.

A) ENFOQUE DE RIESGO EN LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA

Para identificar oportunamente las mujeres que tienen mayor predisposición para presentar complicaciones de la gestación, es necesario que las pacientes acudan a consulta médica desde que se saben embarazadas. A las consultas y cuidados que se dan a una mujer durante el embarazo se les llama **control prenatal**; éste consiste en un conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal. Sus objetivos primordiales son identificar factores de riesgo, diagnosticar las condiciones generales de la madre y del feto, educar a la madre para limitar las posibilidades de complicación y prepararla para el nacimiento de su hijo.¹³ Para poder brindar a cada paciente el cuidado óptimo que requiere, la información que se obtenga en cada visita debe ser tan completa como sea posible, sin importar si se trata de una consulta de rutina o una revisión por un problema específico.¹⁴ (Figura 1)

La acción más relevante realizada por el médico durante el control prenatal, desde la primera consulta, es la identificación de los factores de riesgo que son modificables y dar indicaciones precisas a la paciente, para que se logre la reducción o el control del riesgo.¹⁵ Para lograr el diagnóstico oportuno de las complicaciones, es imprescindible una actitud de sospecha permanente. De la misma magnitud es la acción educativa de enseñar a la paciente a identificar *los datos de alarma* y cuáles son las acciones que debe realizar en caso de que éstos se presenten. (Figura 2)

Aproximadamente el 70% de la población obstétrica no tiene factores de riesgo, su control es simple, y no requiere de infraestructura de alto costo. El equipamiento básico que requiere el obstetra consiste en un lugar físico con iluminación y clima adecuados, una mesa ginecológica, esfigmomamómetro, termómetro, báscula clínica con altímetro, cinta métrica, estetoscopio de Pinard, guantes de examen ginecológico, espéculos vaginales y expediente clínico.^{16 17} El 30% restante de los casos, sin embargo, puede requerir de recursos tecnológicos básicos como ultrasonógrafo, monitor fetal o cardiotocógrafo, por lo que una situación de carencia o insuficiencia podría ser subsanada solicitando el estudio específico requerido para el caso particular, a otra unidad médica de mayor complejidad.

El control prenatal con enfoque de riesgo, ha sido recomendado con un mínimo de 5 consultas para cada embarazo, por la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio,¹⁸ así como en la Guía de práctica clínica para el control prenatal con enfoque de riesgo.¹⁵ (Cuadro 1)

Acciones para un control prenatal seguro



1 Primera consulta: elabora una historia clínica completa con exploración mamaria y solicita una biometría hemática, glucemia en ayuno, grupo sanguíneo y RH. En caso de anemia severa, diabetes, hipertensión o RH negativo, debes referir al hospital.

2 Realiza un examen ginecológico cuidadoso para identificar procesos infecciosos o tumorales.
> Se puede posponer al segundo trimestre e incluir la toma de muestra para Papanicolaou.

3 Mide signos vitales, peso y la altura uterina en todas las consultas clínicas, y continúa la provisión de suplementos de hierro+ácido fólico.

> A partir de la 2da mitad del embarazo debes auscultar la frecuencia cardíaca fetal y preguntar sobre los movimientos fetales.

En todas las consultas busca síntomas y signos de riesgo, que son motivo de referencia inmediata al hospital:

- > Cefalea, acúfenos, fosfenos, visión borrosa, mareo, náusea/vómito, dolor en epigastrio o en el cuadrante superior derecho.
- > Sangrado transvaginal en cualquier trimestre.
- > Dolor abdominal relacionado o no a trabajo de parto.
- > Disminución de los movimientos fetales.
- > Edema generalizado.

5 Durante el control prenatal solicita siempre la prueba de sífilis y oferta la de VIH (con el consentimiento de la paciente).

6 Administra 2 dosis de toxoide tetánico (1er trimestre - 3er trimestre). Las embarazadas también se deben vacunar contra la influenza.

7 En cada consulta de la 2da mitad del embarazo debes realizar una prueba en orina con tira reactiva para detectar proteinuria o infección de vías urinarias (nitritos o sangre).

Considera que el control prenatal consta de importantes elementos educativos:

- > En todas las consultas se debe reforzar la información sobre síntomas de alarma.
- > Participar con la mujer y con su familiar en la elaboración de un plan de seguridad.
- > Promocionar la lactancia materna exclusiva al menos 6 meses post-parto y anticoncepción post-evento obstétrico.

9 Recuerda que existen medicamentos que se pueden utilizar con seguridad durante el embarazo (revisa antes de prescribir). No tratar las infecciones detectadas puede provocar problemas graves como el parto prematuro.

10 Debes insistir en que la mujer no se exponga a alcohol, humo de tabaco u otras drogas.



Figura 1. Diez acciones para un control prenatal seguro.

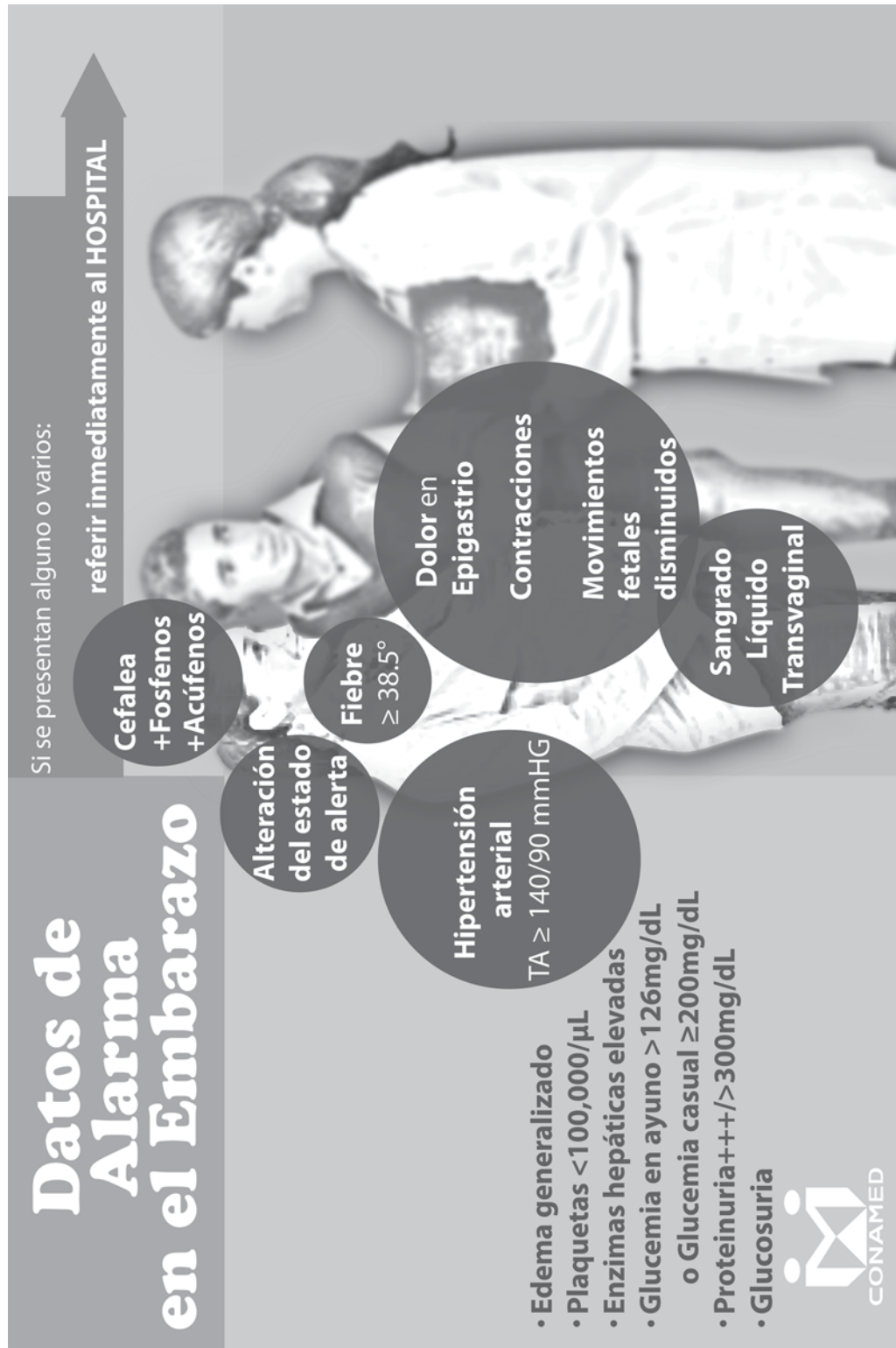


Figura 2. Datos de alarma en el embarazo. Ante la identificación de uno de estos síntomas, signos y resultados de laboratorio, es necesario referir inmediatamente a la paciente al hospital.

Cuadro 1. Actividades a realizar durante el Control Prenatal con enfoque de riesgo:

CONSULTA	ACTIVIDADES		
Primera (en las primeras 12 semanas o en cuanto se reconoce como embarazada)	a) Elaboración de historia clínica, valoración del riesgo obstétrico y establecimiento del diagnóstico integral; b) Identificación de signos y síntomas de alarma (cefalea, edemas, sangrados, signos de infección de vías urinarias y vaginales), así como estado de salud del feto; c) Medición y registro de peso, talla, crecimiento uterino, y presión arterial, así como interpretación y valoración; d) Determinación de biometría hemática completa, glucemia y VDRL (en la primera consulta; en las subsecuentes dependiendo del riesgo), grupo sanguíneo ABO y Rho, examen general de orina, detección del virus de la inmunodeficiencia adquirida humana VIH (bajo conocimiento y consentimiento de la mujer); e) Prescripción profiláctica de hierro y ácido fólico, y aplicación de al menos dos dosis de toxoide tetánico; la prescripción de otros medicamentos sólo con indicación médica; f) Orientación nutricional y promoción para que la mujer acuda a consulta con su pareja o algún familiar, para integrar a la familia al control de la embarazada; g) Promoción y orientación sobre planificación familiar, lactancia materna exclusiva y medidas de autocuidado de la salud. h) Elaboración del Plan de Seguridad Obstétrica.		
En cada consulta (mínimo 5 consultas):	2ª	22-24 semanas de gestación (SDG)	Evaluación clínica general y en busca de datos de alarma. Revisión y actualización del Plan de Seguridad Obstétrica. Glicemia de ayuno, EGO. Otros según riesgo obstétrico.
	3ª	27-29 SDG	Evaluación clínica general y en busca de datos de alarma. Revisión y actualización del Plan de Seguridad Obstétrica. Glucemia de ayuno, EGO. Otros según riesgo obstétrico.
	4ª	33-35 SDG	Evaluación clínica general y en busca de datos de alarma. Revisión y actualización del Plan de Seguridad Obstétrica. EGO, promoción de lactancia materna (LM) y planificación familiar (PF). Otros según riesgo obstétrico.
	5ª	38-40 SDG	Evaluación clínica general y en busca de datos de alarma. Evaluación de vía de nacimiento. EGO, promoción de LM y PF. Otros según riesgo obstétrico.

La NOM-007-SSA2-1993 y la Guía de práctica clínica para el control prenatal con enfoque de riesgo (Supervisión del embarazo normal), establecen una serie de actividades mínimas que el profesional de la salud deberá realizar durante el Control Prenatal. En el Cuadro 1 se presenta una clasificación ampliada de los riesgos reproductivo y obstétrico que hemos denominado *Semáforo del riesgo prenatal*. (Cuadro 2)

Cuadro 2. Semáforo del riesgo prenatal.

	RIESGO REPRODUCTIVO		RIESGO OBSTÉTRICO	
	ANTECEDENTES PREVIOS AL EMBARAZO		COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO	
Dos o más	- Edad <15 años o >40 años - Talla <1.44 metros - IMC <17 o >30 (inicio del embarazo) - Nivel socioeconómico muy bajo - Analfabeta o no habla español - Enfermedades crónicas: HAS, DM, cardiopatías, endocrinopatías, etc. - Antecedentes obstétricos: - Preeclampsia - Rh negativo isoinmunizada - Enfermedades de transmisión sexual: - abortos consecutivos espontáneos - cesáreas previas - partos pretérmino - muertes perinatales - cirugías pélvicas previas		- Paciente >28 SDG sin CP previo - Paciente con embarazo >41 SDG - Embarazo múltiple - Complicaciones del presente embarazo: - Anemia (hemoglobina <8 g/dL) - Placenta previa no sangrante - Glicemia de ayuno >125 mg/dL - Tabaquismo o toxicomanías activas - Crecimiento uterino discordante - Aumento de peso >15 kg - Incompetencia istmicocervical - Trastornos depresivos	- Hipertensión arterial >160/110 mmHg - Hemorragia obstétrica activa - Dolor abdominal intenso y constante - Dolor en epigastrio o CSD (en barra) - Cefalea intensa - Acúfenos, fosfenos o visión borrosa - Edema facial o abdominal - Fiebre (>38°) - Amenaza de aborto o parto pretérmino controlada - Ausencia de movimientos fetales >3 h - Glicemia casual >200 mg/dL - Proteinuria >5g (orina 24 h) >++ (tira) - Creatinina sérica elevada (>1.2 mg/dL) - Enzimas hepáticas elevadas - Plaquetas disminuidas (<150,000) - Oliguria o hematuria - Naúsea y vómito - Disminución del estado de alerta - Convulsiones
	- Edad 15-19 años o 36-40 años - Talla 1.45 a 1.50 metros - IMC 17-19 o 25-29 - No unida (soltera, separada, viuda) - Nivel educativo <primaria incompleta - Nivel socioeconómico bajo - Domicilio alejado de unidad médica 2 horas o más - No conciliación/rechazo del embarazo - Periodo intergenésico corto <18 meses - Madre o hermana con preeclampsia - Antecedente de infertilidad		- Paciente 22-28 SDG sin CP previo - Embarazo gemelar no complicado - Embarazo con DIU in situ - Antecedentes obstétricos: - Aborto espontáneo - Muerte perinatal - Cesárea previa - Cirugía pélvica previa - Parto pretérmino - Malformaciones fetales - Bajo peso al nacer - Hijo macrosómico (>3500 g) - Rh negativa no isoinmunizada	- Complicaciones del presente embarazo: - Anemia (hemoglobina de 12 a 8 g/dL) - Hipertensión arterial >140/90 mmHg - Infecciones genito repetidas - HAS o DM controlada - Hemorragia obstétrica controlada - Amenaza de aborto o parto pretérmino controlada - Ruptura de membranas <12 h - Movimientos fetales disminuidos > 3 h - Glicemia de ayuno 91-125 mg/dL - Proteinuria >300dL (orina 24h) ó + (tira) - Oligohidramnios o polihidramnios
	PLAN DE SEGURIDAD OBSTÉTRICA - Paciente sin antecedentes o complicaciones con embarazo normoevolutivo. - Paciente con complicaciones controladas, valorada por médico especialista en ginecología y obstetricia y contrareferida para control en primer nivel de atención. - Cuáles son los datos de alarma y qué hacer si se presentan a quién llamar o a dónde acudir - Dónde puede recibir atención de urgencia durante el embarazo y cómo llegar (ruta, medio de transporte) - Fecha probable del nacimiento y dónde se atenderá el nacimiento - Qué documentos y objetos debe llevar - Quiénes (familiares, amigos, compañeros de trabajo) y cómo participarán en el Plan de Seguridad, incluyendo la seguridad logística doméstica (hijos, trámites, etc.) - Consejería sobre métodos de planificación familiar			

Abreviaturas: CP = Control prenatal * SDG = Semanas de gestación * IMC = Índice de masa corporal * CSD = Cuadrante superior derecho + HAS = Hipertensión arterial sistémica * DM = Diabetes mellitus * SAE = Servicios de atención obstétrica de emergencia. Fuente: Guías Nacionales de Práctica Clínica relacionadas con la atención obstétrica: Diagnóstico y tratamiento de la infección del tracto urinario bajo, durante el embarazo, Diagnóstico de enfermedad hipertensiva del embarazo, Diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo, Diagnóstico y manejo del parto pre término, Prevención primaria y tamizaje del parto pretérmino en el primer nivel de atención, Prevención y manejo de la hemorragia postparto en el primer y segundo niveles de atención, Inducción de trabajo de parto, Vigilancia y manejo del parto, Hipertiroidismo con o sin crisis hipertiroides en el embarazo, parto y puerperio. www.cenetec.salud.gob.mx

Con el apoyo de los datos anteriores, se deben detectar factores que puedan complicar el embarazo y establecer los criterios de referencia para la atención de las gestantes a las unidades de primero, segundo y tercer niveles. Para ello, existen herramientas como el *Gestograma para el Control Prenatal Seguro*¹⁹ (Anexo I); su función básica es auxiliar al profesional de la salud en el cálculo de la edad gestacional y la fecha probable de parto a partir de la fecha de la última menstruación o de la traspolación de la fecha de un ultrasonograma (embarazadas con amenorrea no confiable). Además agrega los cuidados mínimos a realizar durante la atención a la mujer embarazada en México, organizados por consulta y edad gestacional, fundamentados en documentos normativos: Guías nacionales de práctica clínica, Lineamientos técnicos, Normas oficiales mexicanas y bibliografía representativa.* (Figura 3. Anverso y Reverso)

Una actividad educativa muy importante es la elaboración del Plan de Seguridad Obstétrica, desde la primera consulta. Es necesario revisarlo en cada consulta para hacer las adecuaciones pertinentes. Este Plan consiste en que la paciente y sus familiares o su red de apoyo, reflexionen y prevean situaciones que pueden resultar conflictivas o incluso determinantes al momento de resolver una emergencia obstétrica o al momento del nacimiento.²⁰ (Cuadro 3)

Cuadro 3. Plan de Seguridad Obstétrica

PLAN DE SEGURIDAD OBSTÉTRICA
▪ Cuáles son los datos de alarma y qué hacer si se presentan, a quién llamar o a dónde acudir ▪ Dónde puede recibir atención de urgencia durante el embarazo y cómo llegar (ruta, medio de transporte). ▪ Fecha probable del nacimiento y dónde se atenderá el nacimiento ▪ Qué documentos y objetos debe llevar ▪ Quiénes (familiares, amigos, compañeros de trabajo) y cómo participarán en el Plan de Seguridad, incluyendo la logística doméstica (hijos, trámites, etc.) ▪ Consejería sobre anticoncepción posevento obstétrico (APEO) y planificación familiar.

Fuente: Freyermuth G, Meléndez D, Meneses S. Plan de Seguridad: un modelo de diseño y puesta en marcha de acciones para disminuir la muerte materna. Rev Mujer y Salud (Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe). 2008; 4:76-80.

El **riesgo reproductivo** es la probabilidad de enfermedad o muerte que tienen la mujer y/o su futuro hijo en caso de embarazo en condiciones no ideales;²¹ es decir, todos aquellos factores externos o intrínsecos a la mujer, que puedan desarrollar alguna complicación durante la evolución del embarazo, el desarrollo del parto, del puerperio o que puedan alterar de alguna forma el desarrollo normal o la supervivencia del producto.²²

* El GESTOGRAMA PARA EL CONTROL PRENATAL SEGURO (disponible en <http://www.conamed.gob.mx/gestograma.html>) no es una revisión o compilación exhaustiva ni excluyente en cuanto al cuidado prenatal. Para conocer el marco técnico-normativo del control prenatal en nuestro país, se recomienda revisar los siguientes repositorios: el Catálogo Maestro de Guías Nacionales de Práctica Clínica <http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/catalogoMaestroGPC.html>, la Normateca en Salud http://www.comeri.salud.gob.mx/interior/bicentenario/normativigente_axo.html, los lineamientos técnicos publicados por el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva <http://www.generoysaludreproductiva.salud.gob.mx/>, así como las Recomendaciones para mejorar la práctica médica publicadas por CONAMED. <http://www.conamed.gob.mx/recomendaciones.html>.

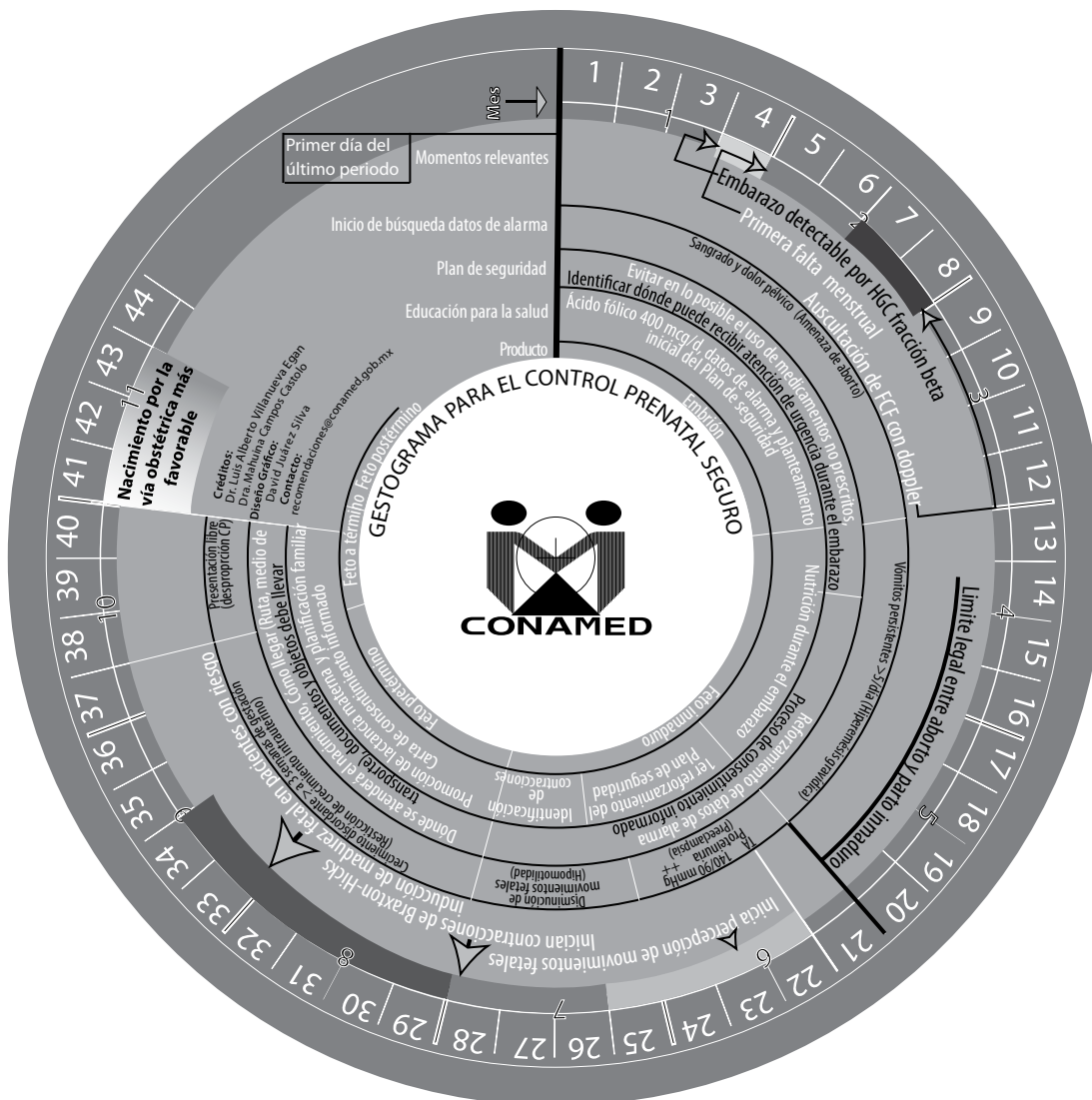


Figura 3. Gestograma para el Control Prenatal-Seguro Anverso. Presenta un disco central con doble cara, que marca los meses y los días y dos discos externos:

- *Semanas.* Se refiere a las semanas de gestación e identifica desde el primer día del último periodo menstrual o Fecha de Última Menstruación (FUM), hasta la semana 44. *Mes.* Establece meses lunares (1 mes = 4 semanas).
 - *Momentos relevantes.* Señala periodos con relevancia clínica o médico-legal durante la atención obstétrica.
 - *Inicio de búsqueda (de) datos de alarma.* Conforme a la evolución del embarazo, existen diversos riesgos para el binomio madre-feto, por lo que se señala el momento en que se debe comenzar a buscar, de manera intencionada, la presencia del dato de alarma señalado. Los datos de alarma son sumativos durante la gestación y debe documentarse en el expediente clínico, el resultado de la búsqueda intencionada, sea positiva (se encontró el dato de alarma) o negativa (no se encontró el dato de alarma).
 - *Plan de seguridad obstétrica.* Busca orientar y educar a la embarazada y a su familia cercana, en la identificación temprana de datos de alarma y la planeación de acciones que permitan reducir la emergencia obstétrica.
 - *Educación para la salud.* Temas a tratar con la embarazada durante las consultas.
 - *Producto.* Denominación científica apropiada del producto de la concepción, de acuerdo a su evolución.
- Puede descargarlo de **<http://www.conamed.gob.mx/gestograma.html>**.

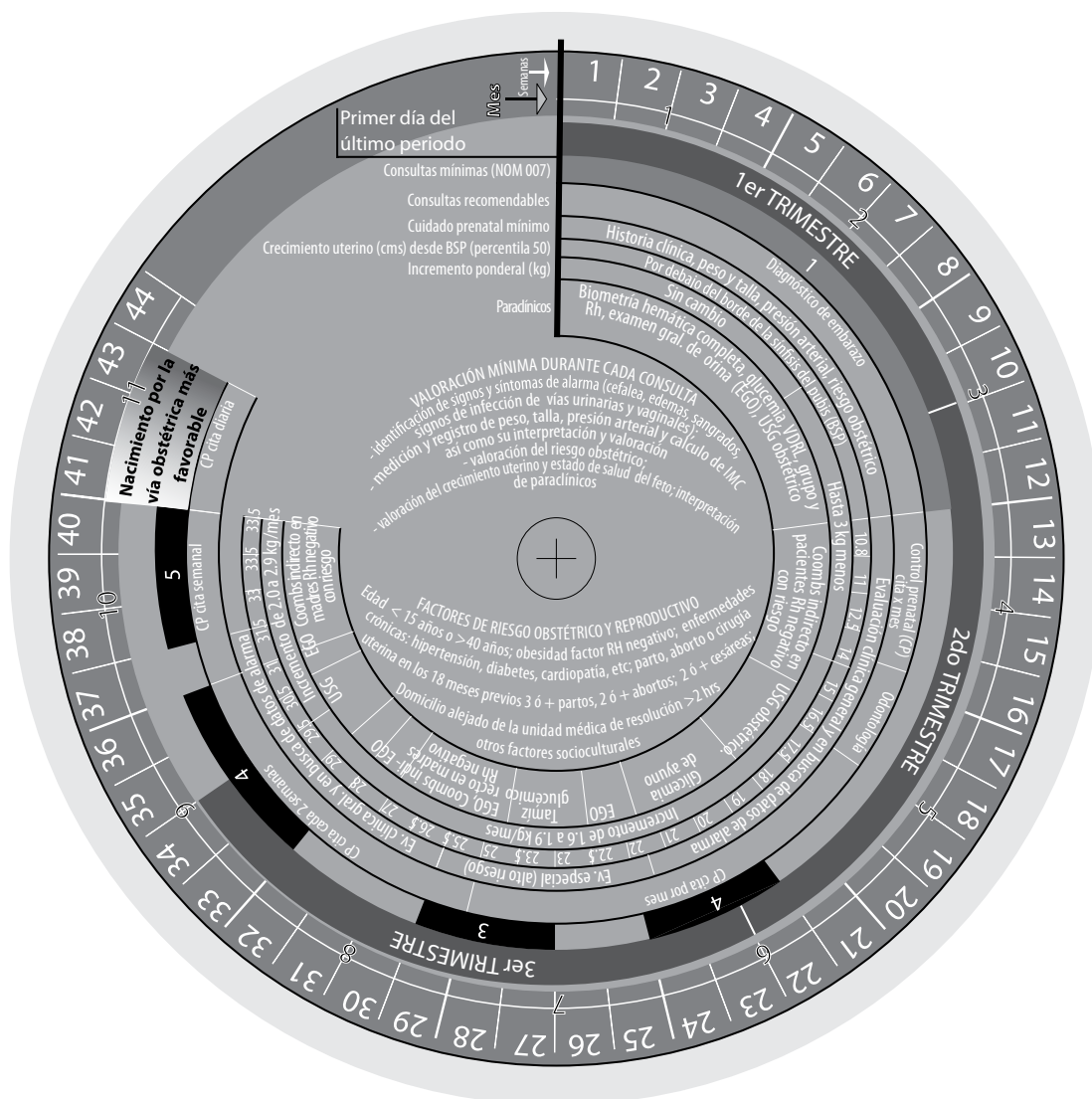


Figura 4. Gestograma para el Control Prenatal Seguro-Reverso. Disco 2 (reverso). Al centro del disco describe la Valoración mínima durante cada consulta que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993:

- **Consultas mínimas.** Calendariza los periodos aproximados para las consultas prenatales mínimas en la embarazada de bajo riesgo, iniciando preferentemente antes de la semana 12.
- **Consultas recomendables.** Recomendaciones internacionales sobre frecuencia y acciones de salud básicas.
- **Cuidado prenatal mínimo.** Actividades mínimas que se deben realizar durante el control prenatal (NOM 007).
- **Crecimiento uterino (cms) desde BSP (percentila 50).** Evolución del crecimiento uterino promedio desde el borde de la sínfisis del pubis (BSP), equivalente a la percentila 50 según curvas de crecimiento.
- **Incremento ponderal.** Modificación en el peso, a partir del peso real de la mujer antes del embarazo.
- **Paraclínicos.** Estudios paraclínicos mínimos recomendados durante el control prenatal.

El **riesgo obstétrico** es la probabilidad de enfermedad o muerte que tienen la mujer o su futuro hijo en un embarazo presente. El análisis de la distribución poblacional de la patología obstétrica, tanto durante la gestación como durante el parto, permite notar que esta se encuentra en determinados grupos de mujeres, en los que la morbimortalidad materna fetal están notablemente incrementadas respecto a la media de su entorno.²²⁻²⁵

Un **embarazo de alto riesgo** es aquél en el que existe la probabilidad de daño grave o muy trascendente de morbilidad o mortalidad para la madre, el feto o el neonato. Estos incluyen factores maternos generales como edad (los extremos de la vida reproductiva), condiciones nutricionales, nivel socioeconómico y cultural, hábitos nocivos (alcoholismo, tabaquismo), antecedentes obstétricos (pérdidas gestacionales recurrentes, multiparidad, enfermedades asociadas (cardiopatías, diabetes mellitus, hipertensión, nefropatías, etc.), y anomalías del embarazo actual (alto orden fetal, presentaciones anormales, hidramnios, etc).²²⁻²⁵

La omisión de antecedentes ginecoobstétricos que permitan realizar una valoración adecuada del riesgo obstétrico puede explicarse por impericia, al pasar por alto circunstancias relevantes.⁵
⁷⁻¹² Puede evitarse utilizando tablas de riesgo obstétrico que permitan una calificación objetiva.⁶
⁸⁻¹⁰ Así se puede prever la necesidad de un especialista y contar a la brevedad con recursos materiales, como los hemoderivados para los casos de alto riesgo. Es importante consignar en el expediente médico la evolución del trabajo de parto, las condiciones y vía del nacimiento, los procedimientos quirúrgicos y materiales utilizados, hallazgos, incidentes y detallar el tratamiento empleado, datos que tienen gran trascendencia si la paciente es trasladada a otra institución.
¹¹⁻¹⁴ Los factores de riesgo para hemorragia durante la cesárea son preeclampsia, distocias de contracción, antecedente de hemorragia en partos previos, obesidad, uso de anestesia general e infección intraamniótica.⁵⁻⁶⁻¹⁵

El diagnóstico temprano permite el tratamiento adecuado y oportuno, la prevención de complicaciones y limitación del daño. Si no se cuenta con los recursos humanos, materiales e instalaciones necesarios, debe referirse al siguiente nivel de atención en cuanto se detecten complicaciones, pues los hospitales de apoyo pueden ser distantes, principalmente en el caso de las unidades médicas rurales.¹⁻²⁶

B) ATENCIÓN CALIFICADA DEL PARTO

Del latín partus, el parto “normal” es el proceso mediante el cual el producto de la concepción y sus anexos son expulsados del organismo materno a través de las vías genitales, con un embarazo mayor de 20 semanas y un producto de 500 g o más.²⁷ Así, representa el evento obstétrico donde los fenómenos locales activos y pasivos, los cambios anatómicos de los órganos maternos, la dinámica uterina, la expulsión del feto y anexos ovulares y la pérdida sanguínea ocurren dentro de la secuencia, magnitud, topografía y duración aceptadas como naturales, sin interferencias, accidentes o complicaciones que ameriten la intervención terapéutica.

Más allá del control prenatal con enfoque de riesgo, Un punto de extraordinaria importancia para reducir las complicaciones y la mortalidad materna es reconocer que TODO EMBARAZO ESTÁ EXPUESTO A RIESGO. Toda mujer tiene cierta probabilidad de sufrir algún daño en su salud

durante cada gestación, y existe insuficiencia de profesionales de la salud que puedan atender a los dos y medio millones de mujeres mexicanas que se embarazan cada año. Las complicaciones son difíciles de prever y requieren de personal calificado: partera profesional, enfermera profesional, obstetra competente, capaz de manejarlas apropiadamente y referir a las madres a los centros de salud y hospitales si se requiere atención especializada. Solo 53% de los partos en los países en desarrollo fueron atendidos por obstetras competentes, sobre todo en las áreas rurales.²⁸

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), define como *personal calificado* a “una persona con destrezas para brindar todo tipo de cuidados maternos, desde antes del embarazo hasta el período de posparto, incluyendo los cuidados obstétricos esenciales”.²⁹ (Cuadro 4) La OMS, la Confederación Internacional de Matronas y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia especifican que puede tratarse de parteras, médicos y enfermeros “capacitados y competentes en manejar embarazos normales (sin complicaciones), partos y el periodo postnatal inmediato; y que son capaces de identificar complicaciones, y manejarlas o referir a la mujer y el recién nacido”. Así, la atención calificada es un “proceso que favorece la prevención de complicaciones y la detección oportuna de señales de peligro, aunque es obvia la necesidad de calificación para resolver las emergencias”.³⁰

Cuadro 4. Cuidados maternos recomendados para mejorar el acceso a una atención calificada del parto (OPS).

CUIDADOS OBSTÉTRICOS ESENCIALES	CUIDADOS OBSTÉTRICOS INTEGRALES
- Prevenición, detección oportuna y Tratamiento del embarazo con problemas (anemia, diabetes, VIH/SIDA); - Tratamiento médico de las complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el aborto (hemorragia, septicemia, complicaciones del aborto, eclampsia); - Procedimientos manuales (retiro de la placenta, sutura de desgarros o episiotomías); - Vigilancia de la dilatación (aplicando el partograma); y - Atención neonatal básica.	- Cuidados obstétricos esenciales - Intervenciones quirúrgicas (cesáreas) - Anestesia - Transfusión sanguínea.

Fuente: Family Care International. La atención calificada durante el parto. Un cuaderno informativo. Nueva York, 2003.

Existen vastas disparidades sobre la competencia de quienes brindan la atención obstétrica entre las regiones: en Sud Africa, casi 80% de las mujeres son atendidas por personal calificado competente, mientras en el resto de África, la tasa es cerca del 40%, y en el sureste-centro de Asia apenas llega al 34%. En nuestro país, se estima que en el periodo 2000-2003, más del 70% de los nacimientos son atendidos por personal competente (médicos, parteras empíricas, enfermeras obstetras u otro personal auxiliar de salud).³¹

Las condiciones de salud de las mujeres mexicanas ha mejorado apreciablemente en las últimas cuatro décadas, aunque todavía existen problemas de consideración. Una causa muy importante de esta situación es la insuficiencia de personal de salud. Algunos reportes sugieren 8 médicos por cada 10 000 habitantes y una *densidad de recursos humanos para la salud* (incluye médicos y enfermeras) de 25.³² En 2011, se contabilizaron 1.7 médicos en contacto con el

paciente por cada 1,000 habitantes, 3.0 ginecoobstetras por cada 1,000 mujeres entre 15 y 44 años, y 5.3 pediatras por cada 1,000 habitantes menores de un año.³³

Los estudios realizados sugieren que la presencia de personal calificado en el momento del parto es una de las intervenciones clave para reducir la mortalidad materna y perinatal, pues cuando se presentan complicaciones en el momento del parto, los que lo atienden, deben ser aptos para aplicar medidas de emergencia en ausencia de asistencia médica o referir a las mujeres a la unidad de salud apropiada.^{5 6 10}

El impacto del control prenatal en la salud materna y perinatal sólo se verificará si TODAS las mujeres embarazadas tienen garantizado en acceso oportuno y de calidad para la atención de su embarazo, parto y puerperio, incluyendo la atención de la emergencia obstétrica.

Una estrategia que ha demostrado la capacidad de mejorar la atención obstétrica en el mundo, es la iniciativa *Diez Principios de Cuidado Perinatal de la OMS*.³⁴ Este documento, publicado en 2001, tiene sustento en medicina basada en evidencia y establece acciones a seguir en el embarazo y parto normales. (Cuadro 5) En este estudio, Chalmers revisó 7500 partos atendidos por 350 parteras profesionales en la casa de las pacientes durante 2000: 88% fueron partos normales en casa, 12% requirieron atención adicional en hospitales, la tasa de cesáreas fue de 3.7% y 2 muertes perinatales por 1000 nacimientos, generalmente por causas genéticas. Sus conclusiones fueron que el parto en casa, asistido por partera capacitada, es igual de seguro a un parto de bajo riesgo atendido en un hospital. (Cuadro 5)

Cuadro 5. Diez principios básicos (Chalmers et al. Birth 2001; 28: 202-207).

DIEZ PRINCIPIOS BÁSICOS Aseguran fuertemente la protección, la promoción y el soporte necesario para lograr un cuidado perinatal efectivo.	1° La atención del embarazo y parto normales deben ser “desmedicalizadas”, reduciendo al mínimo el número de intervenciones y aplicar la menor tecnología posible. 2° Uso de tecnología apropiada, lo que se define como un conjunto de acciones que incluye métodos, procedimientos, tecnología, equipamiento y otras herramientas, todas aplicadas a resolver un problema específico. Este principio está dirigido a reducir el uso excesivo de tecnología o la aplicación de tecnología sofisticada o compleja cuando procedimientos más simples pueden ser suficientes o aún ser superiores. 3° Basado en las evidencias, lo que significa avalado por la mejor evidencia científica disponible, y por estudios controlados aleatorizados cuando sea posible y apropiado. 4° Regionalizado y basado en un sistema eficiente de referencia de centros de cuidado primario a niveles de cuidado terciarios.
---	--

Continúa el Cuadro 5 en la siguiente página

DIEZ PRINCIPIOS BÁSICOS	5° Ser multidisciplinario, con la participación de profesionales de la salud como parteras, obstetras, neonatólogos, enfermeras, educadores del parto y de la maternidad y científicos sociales. 6° Ser integral y debe tener en cuenta las necesidades intelectuales, emocionales, sociales y culturales de las mujeres, sus niños y familias y no solamente un cuidado biológico. 7° Estar centrado en las familias y debe ser dirigido hacia las necesidades no solo de la mujer y su hijo, sino también tomar en cuenta las necesidades de su pareja. 8° Ser apropiado teniendo en cuenta las diferentes pautas culturales para permitir y lograr sus objetivos. 9° Tener en cuenta la toma de decisión de las mujeres. 10° Respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres.
--------------------------------	---

La OMS establece además, las prácticas recomendadas y las intervenciones inapropiadas que están ampliamente difundidas en el mundo y que no solamente no han demostrado ser benéficas, sino que incluso se han evidenciado como dañinas, por lo cual deben ser abandonadas. (Cuadro 6) El seguimiento de estas recomendaciones fundamenta el llamado *parto humanizado*, que está basado en el respeto a los derechos humanos y las necesidades emocionales, físicas, psíquicas y sociales de la mujer, su neonato y su familia y sustentado en la mejor evidencia científica.

Cuadro 6. Prácticas recomendadas por la OMS para la atención del parto.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS POR LA OMS (WHO/FRH/MSM/96.24)	1. Permitir que las mujeres tomen decisiones acerca de su cuidado. 2. Acompañamiento continuo durante el trabajo de parto y parto. 3. Libertad de movimiento y posición durante el trabajo de parto y parto. 4. No hacer episiotomía de rutina. 5. No hacer rasurado y enema de rutina. 6. No hacer monitoreo fetal electrónico de rutina. 7. Permitir toma de líquidos y alimentos en trabajo de parto. 8. Restringir el uso de oxitocina, analgesia y anestesia. 9. Limitar la tasa de cesárea al 10-15%.
PRÁCTICAS DAÑINAS (WHO/FRH/MSM/96.24) La OMS invita a abandonar las siguientes prácticas que, a pesar de ser muy difundidas, han demostrado ser dañinas.	1. Suplementos de hierro si no están indicados, sabiendo que un nivel de hierro más bajo es fisiológico durante el embarazo. 2. Evaluaciones perinatales con enfoque de riesgo, ya que las mismas no pueden predecir quiénes desarrollarán complicaciones. 3. Uso rutinario de exámenes ecográficos durante el embarazo.

Continúa el Cuadro 6 en la página siguiente

PRÁCTICAS DAÑINAS (WHO/FRH/MSM/96.24)	3. Prohibición del acompañamiento por un familiar. 4. Rasurado, enema y monitoreo fetal electrónico rutinarios. 5. Restricción de líquidos y comidas ligeras durante el trabajo de parto. 6. Exámenes vaginales frecuentes para evaluar el progreso en trabajo de parto normal. 7. Inducción del parto en forma rutinaria antes de las 42 semanas. 8. Uso de sedantes /tranquilizantes de rutina. 9. Infusión intravenosa de rutina en el parto. 10.Despegue de membranas y amniotomía para la inducción del trabajo de parto. 11.Administración de oxitócicos en trabajo de parto y uso de ergometrina en la tercera fase del parto. 12.Restricción de la posición materna durante el trabajo de parto y posición horizontal durante el parto. 13.Episiotomía rutinaria. 14.Esfuerzos de pujo sostenidos y dirigidos (maniobra de Valsalva y Kristeller).
--	---

C) USO SEGURO DE LA OXITOCINA EN LA ATENCIÓN DEL PARTO

La oxitocina es el fármaco más utilizado en la obstetricia moderna y apoya al obstetra a resolver distintas situaciones clínicas potencialmente graves. Sus indicaciones son: inducción y conducción del trabajo de parto, alumbramiento dirigido y apoyo de la hemostasia posaborto, posparto y poscesárea. Sin embargo, es necesario tener siempre presente, al momento de la indicación, sus efectos adversos y garantizar los cuidados necesarios, ya que el **uso de oxitocina en obstetricia no debe ser rutinario, sino que su indicación deberá basarse en la evaluación individualizada de cada paciente y estar adecuadamente justificado en el razonamiento clínico.**³⁶

Una revisión sistemática del *Child and Pregnancy Cochrane Group*, que incluyó a 1338 pacientes de bajo riesgo durante el período de dilatación del trabajo de parto espontáneo a término, en 8 estudios, encontró que la administración temprana de oxitocina como tratamiento para la evolución lenta del trabajo de parto, produjo una reducción estadísticamente significativa en la duración media del trabajo de parto de aproximadamente dos horas. Sin embargo, el uso de oxitocina no aumentó la cantidad de partos normales; tampoco redujo la indicación de cesárea ni los partos asistidos con fórceps. No hubo diferencias con respecto al uso de analgesia epidural. Al parecer no ocasiona daños maternos ni fetales, aunque el tamaño de la muestra fue muy pequeño para establecer si su utilización afecta las tasas de morbi-mortalidad neonatal.³⁷

Riesgos durante la inducción y conducción del trabajo de parto

El parto inducto-conducido mediante oxitocina presenta más complicaciones que el trabajo de parto espontáneo, especialmente en paciente primíparas, por lo cual es muy importante una indicación correcta y razonada, que evalúe cuidadosamente el riesgo-beneficio para el binomio. Otros puntos indispensables a valorar son la edad gestacional (para prevenir la prematuridad

yatrógena) y el método de inducción que sea más adecuado para la paciente, la institución y los profesionales de la salud a cargo.³⁸

Valoración previa y requisitos para la inducción con oxitocina

- Revisar la historia clínica con énfasis en la edad gestacional, paridad, antecedentes de riesgo: cesárea o cirugía uterina previa, factores de sobredistensión uterina (embarazo múltiple, polihidramnios, feto grande sin desproporción cefalopélvica) y otras anomalías del canal de parto.
- Descartar contraindicaciones: dos o más cesáreas o cirugías uterinas previas, incisiones corporales o en T invertida, miomectomía con entrada a la cavidad uterina, antecedente de ruptura uterina, situación no cefálica del feto único, placenta previa oclusiva, vasa previa, insuficiencia placentaria severa y herpes genital activo.
- Evaluar mediante palpación bimanual: pelvis materna, estado de las membranas corioamnióticas e Índice de Bishop (Cuadro 7), así como tamaño y presentación del feto, para descartar riesgos y contraindicaciones.

Cuadro 7. Índice de Bishop. En el caso de que la inducción del parto esté indicada, una valoración del índice de Bishop igual o menor de 6 se considera un cérvix desfavorable, por lo cual está indicada la maduración cervical con prostaglandinas o métodos no farmacológicos previa a la inducción del parto con oxitocina.

Parámetro/Valor		0	1	2	3
Cérvix uterino	Dilatación	0	1-2 cm	3-4 cm	>5 cm
	Borramiento/ longitud	0-30% 4 cm o má	40-50% 2-3 cm	60-70% 1 cm	80-100% <1 cm
	Consistencia	Firme ("como la punta de la nariz")	Reblandecida	Blanda ("como el labio inferior")	Muy blanda
	Posición	Posterior	Media	Anterior	Anterior
Altura de la presentación / Estado de la cabeza fetal (cm desde las espinas isquiáticas)		Libre (-3)	Insinuado (-2)	1er plano (-1/0)	2do plano (+1/+2)

- Valorar la presentación, estado de las membranas amnióticas y condiciones obstétricas.
- Evaluar las condiciones fetales y su respuesta al estímulo oxitócico durante todo el procedimiento.
- SIEMPRE se debe DOCUMENTAR la indicación justificada para la inducción, la evolución del procedimiento mediante partograma y realizar el proceso de consentimiento informado con la paciente.³⁶⁻³⁸

D) COMPLICACIONES EN OBSTETRICIA

Las complicaciones obstétricas ocupan uno de los primeros lugares como causa de mortalidad hospitalaria y de mortalidad general,⁴ y se les define como cualquier contratiempo, acontecimiento o accidente que ponga en peligro la vida de una mujer y/o de su producto durante el embarazo, parto o puerperio, y/o que origine secuelas graves e incluso la muerte.³⁹

Las complicaciones obstétricas pueden derivar en *emergencias obstétricas*, que son definidas como: “una complicación clínica o accidente que aparece de forma más o menos intempestiva en una mujer embarazada, parturienta o puerpera, como resultado de complicaciones del proceso de gestación, omisiones y/o errores asistenciales, que ponen en riesgo la salud y vida de la madre y el feto y que requieren atención sanitaria inmediata y apropiada”. (FCI) ³⁴

El documento de la política pública “Estrategia para reducir la mortalidad materna en México”, refiere: “En la actualidad, se presentan 2.1 millones de embarazos cada año, alrededor de 300 mil tienen complicaciones obstétricas. El impacto que estas complicaciones obstétricas siguen teniendo en la país es enorme ya que 30,000 mujeres quedan con secuelas obstétricas que las convierten en discapacitadas, falleciendo anualmente, 1,100 mujeres (lo cual) provoca una secuela social de 3,000 huérfanos cada año. Vale recordar que el 80 por ciento de estas defunciones maternas son prevenibles”.²⁰

El embarazo y el parto son las principales causas de incapacidad y muerte de mujeres de 15 a 49 años: en los últimos 10 años seis millones de mujeres han muerto por esta causa; se calculó que en el mundo, cada día mueren 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto y que ocurre una muerte materna cada minuto.^{37 38} La incapacidad laboral en 2008-2009, relacionada con complicaciones en el embarazo, parto o aborto en mujeres de 15 a 49 años, alcanzó casi 503 mil atenciones, 94.5% de las cuales tuvieron que ausentarse entre uno y trescientos días de su actividad laboral. De este total, 12.9% no regresaron a su actividad laboral.³⁹ Los casos más graves se ejemplifican en un análisis de la muerte materna por emergencias obstétricas en Chiapas, donde representó 84% del total de las defunciones femeninas de 15 a 49 años registradas durante 2001, en ciertos municipios.⁴⁰

Aunque la incidencia de complicaciones obstétricas ha mostrado un descenso importante en los últimos veinte años (en 1980 la tasa de muertes maternas era 15.0 por 100,000 nacidos vivos, y para 1990-2010 era 3.1), el ritmo de descenso está aún lejos de lo requerido para cumplir la *Meta 5.A: Reducir en tres cuartas partes la razón de mortalidad materna entre 1990 y 2015* de los Objetivos del Milenio (ODM 5).⁴¹

Se ha encontrado que las causas que provocan las muertes obstétricas directas están asociadas a complicaciones del embarazo, el parto, el postparto o el aborto, pueden ser **prevenibles** y **evitables**. En México, las complicaciones y las causas biológicas de mortalidad materna* son prácticamente las mismas desde hace décadas: preeclampsia-eclampsia, choque séptico, choque hipovolémico. (Cuadro 8). La tasa de mortalidad materna en nuestro país es de 49.2:100,000 recién nacidos vivos y se calcula que entre el 75% y el 85% de las muertes maternas son previsibles con la tecnología y los recursos adecuados disponibles.⁴²

Según estudios realizados en el Hospital Central Militar y en el Centro Médico de Occidente, el 46.4% de la muertes maternas se relacionan con responsabilidad profesional y 9.7% con responsabilidad hospitalaria. En las estadísticas de la CONAMED se encontró que la especialidad de

* La muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

ginecología y obstetricia ocupa el primer lugar en la proporción de daño permanente y muerte con 53%, relacionado con evidencia de mala práctica.^{6 46 47}

Cuadro 8. Principales causas de Mortalidad Materna en México, 2012.*

CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN CIE-10**	CAUSAS	N	%	RMM***
	Total	809	100	49.2
O10-O16	Enfermedad hipertensiva del embarazo	190	23.5	11.5
O20, O44-O46, O67, O72	Hemorragia del embarazo, parto y puerperio	173	21.4	10.5
A34, O85-O86	Sepsis y otras infecciones puerperales. Septicemia. Causas infecciosas	67	8.3	4.1
O00-O06	Aborto	53	6.6	3.2
B20-B24 más embarazo, F53, M830, O98-O99	Causas Obstétricas indirectas	32	4.0	1.9
	Todas las demás causas de muerte materna	333	41.0	—

* SINAVE. Informe semanal de Vigilancia Epidemiológica, Semana 045.

** Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Décima Revisión. CIE-10. OPS-OMS.

*** Razón de mortalidad materna: Número de defunciones maternas por 100.000 nacidos vivos.

El 28 de mayo de 2009, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado firmaron el Convenio Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas, en el que se establece que todas las mujeres que presenten complicaciones obstétricas deberán ser atendidas en cualquier unidad de salud del IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud, sin importar su afiliación.⁴⁸

Esta iniciativa es de relevancia especialmente durante la resolución del embarazo, ya que la mayor parte de las muertes maternas ocurren durante el parto y el puerperio inmediato, siendo las causas principales hemorragia, sepsis, trabajo de parto prolongado y obstruido, trastornos hipertensivos y complicaciones del aborto. Se estima que al menos el 15% de todos los embarazos requerirán una intervención médica de emergencia, por tanto, el acceso a la atención de la emergencia obstétrica (AEO) es crucial para salvar las vidas de las mujeres embarazadas y sus hijos, así como para prevenir discapacidades en ambos miembros del binomio.

El Convenio define a la *emergencia obstétrica del embarazo, parto y puerperio*, como el “estado nosológico que pone en peligro la vida de la mujer durante la etapa grávido-puerperal y/o al producto de la concepción que requiere de atención médica y/o quirúrgica inmediata por personal médico calificado, adscrito a hospitales con capacidad resolutive suficiente para atender la patología de que se trate”. Las entidades nosológicas que pueden generar emergencia obstétrica, derivada de complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio son:

- a) En cualquier momento del embarazo o el puerperio:
 - Hígado graso agudo del embarazo
 - Trombosis venosa profunda en púerpera
 - Hipertiroidismo con crisis hipertiroidea
 - Embarazo y cardiopatía clase funcional de NYHA II, III y IV
- b) Durante la primera mitad del embarazo:
 - Aborto séptico
 - Embarazo ectópico
- c) Durante la segunda mitad del embarazo, con o sin trabajo de parto:
 - Preeclampsia severa, con manejo inicial durante 4 a 6 horas y pobre respuesta
 - Preeclampsia severa complicada con síndrome de HELLP o insuficiencia renal aguda
 - Eclampsia
 - Placenta previa total con o sin sangrado activo, cualquiera que sea la edad gestacional si el hospital de origen no cuenta con ginecoobstetra ni cirujano.
 - Corioamniotitis
- d) Complicaciones posteriores al evento obstétrico o quirúrgico:
 - Sepsis puerperal, variedades clínicas de la deciduomimetritis o pelviperitonitis
 - Inversión uterina que requiera corrección quirúrgica
 - Hemorragia intraabdominal postquirúrgica de cesárea o histerectomía
 - Trombosis venosa profunda de miembros pélvicos
 - Tromboembolia pulmonar
 - Embolia de líquido amniótico
- e) Otra patología médica u obstétrica, aguda o crónica, que comprometa la vida de la madre o del producto de la concepción y que requiere recibir atención de emergencia (inmediata).

Para establecer el manejo más adecuado ante una paciente con complicaciones del embarazo y con emergencia obstétrica, existen diversas Guías de Práctica Clínica, disponibles en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica, en formato tanto de Evidencias y Recomendaciones (EyR), como las Guías de Revisión Rápida (GRR), disponibles en la dirección electrónica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), <http://www.cenetec.gob.mx>.

Guías de Práctica Clínica recomendadas (mínimas):

- a) Control prenatal con enfoque de riesgo
- b) Detección y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas
 - Detección y Diagnóstico de Enfermedades Hipertensivas del Embarazo

- Atención integral de preeclampsia
- Diagnóstico y tratamiento de la infección del tracto urinario bajo durante el embarazo, en un primer nivel de atención
- Diagnóstico y tratamiento de la hemorragia obstétrica en la segunda mitad del embarazo y puerperio inmediato.
- Diagnóstico y tratamiento de embarazo tubario
- Diagnóstico y manejo de la diabetes en el embarazo
- Prevención, diagnóstico y atención de la rubéola durante el embarazo
- Diagnóstico y manejo de la cardiopatía en el embarazo
- Diagnóstico y tratamiento oportuno de la placenta previa en el segundo y tercer trimestres de embarazo en el segundo y tercer nivel de atención
- Hipertiroidismo con o sin crisis hipertiroidica en el embarazo, parto y puerperio
- Diagnóstico prenatal del síndrome de Down.

E) DEMANDAS POR MALA PRÁCTICA EN OBSTETRICIA

No es posible ignorar el gran impacto de las demandas por mala práctica durante la atención obstétrica, que durante los últimos quince años se han incrementado de manera exponencial y es una de las áreas médicas que se ve involucrada con mayor frecuencia en demandas en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).

En la revisión que realizó el Instituto de Medicina de Estados Unidos en 1989, se encontró una verdadera crisis que afecta la especialidad, la cual afecta a otros países, como Australia. Copeland describió en 1993, que cada día disminuye el número de médicos que practican la obstetricia en ese país, debido principalmente a la creciente amenaza de demandas y los altísimos costos de los seguros de responsabilidad profesional; algunas aseguradoras han llegado a rehusarse a revalidar las pólizas de ginecoobstetras. El resultado final fue la falta de asistencia obstétrica en las áreas rurales.⁴⁹

Pero, ¿porqué demandan a los obstetras? Aunque la vigilancia atenta de los resultados perinatales, en algunos casos ha permitido mejorar algunas prácticas obstétricas, no es razonable suponer que un resultado no óptimo o incluso malo es causado inevitablemente por negligencia o impericia.

La Asociación Médica Mundial (WMA) consideró en su Declaración sobre la Negligencia Médica, adoptada por la 44ª Asamblea Médica Mundial en Marbella, España, en septiembre de 1992, que el aumento de demandas por negligencia médica puede ser el resultado, en parte, de una o más de las siguientes circunstancias:

- a) El progreso en los conocimientos médicos y de la tecnología médica permite que los médicos logren proezas que eran imposibles en el pasado, pero estos logros implican nuevos riesgos que pueden ser graves en varios casos.
- b) La obligación impuesta a los médicos de limitar los costos de la atención médica.
- c) La confusión entre el derecho a la atención, que es accesible, y el derecho a lograr y mantener la salud, que no se puede garantizar.
- d) El papel perjudicial que a menudo representa la prensa (y algunos abogados), al incitar

desconfianza en los médicos y cuestionar su capacidad, conocimientos, conducta y control del paciente y al sugerir a éstos que presenten reclamos contra los médicos.

- e) Las consecuencias indirectas del desarrollo de una medicina defensiva, producidas por el aumento del número de demandas.

En Inglaterra, Lynch⁵⁰ y colaboradores analizaron 500 quejas relacionadas con la especialidad recibidas entre 1984 y 1994; y encontraron que 225 (45%) correspondían a obstetricia. Del total, 46% correspondió a quejas injustificadas, 19% a negligencia, 12% a errores de juicio, 9% a impericia, 7% a comunicación deficiente, 6% a supervisión pobre y 1% a carencias de personal. La causa más frecuente de quejas en obstetricia fue *parálisis cerebral* (22%).

En nuestro país, aún cuando las inconformidades relacionadas a la especialidad ocupan uno de los primeros lugares por frecuencia, existen pocos estudios sobre errores médicos en ginecología y obstetricia, basados todos en la casuística de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Ginecología y Obstetricia, Traumatología y Ortopedia, Cirugía General y Urgencias son las especialidades que se ha mantenido en los nada honrosos primeros lugares de frecuencia de inconformidades presentadas ante CONAMED, de ellos, la que nos ocupa ha representado el 14.5% del total de inconformidades recibidas por la Comisión, durante el periodo 1996-2011.⁵¹

En el 2001, Saucedo-González⁵² identificó que entre junio de 1996 y noviembre de 1998 se presentaron ante la CONAMED 635 quejas relacionadas a Ginecología y Obstetricia, de las cuales, el 60% (375) estaban derivadas de atención obstétrica. Valdés-Salgado⁵³ señala al tratamiento y las intervenciones quirúrgicas como los momentos de la atención médica que ocupan los primeros rubros de conflicto con el 68.2% en conjunto. En el mismo sentido, Campos⁵⁴ reportó lesiones transoperatorias, deficiencias de técnica quirúrgica y problemas de diagnóstico (48%) como causas más frecuentes de queja.

En el estudio ya mencionado, Saucedo identificó como causas más frecuentes de demanda las complicaciones (20%), atención inoportuna (16%), accidentes (15%), acciones inadecuadas (15%) y error diagnóstico (10%). Las quejas se originaron a partir de: cirugía (45%), tratamiento médico (27%) y diagnóstico (13%). Contrasta con los anteriores el reporte de Morales-Ramírez,⁵⁵ que afirma que la mayoría de las quejas por atención ginecológica y obstétrica se generan por percepciones derivadas de resultados inevitables, es decir, por consecuencias de la propia historia natural de los padecimientos gineco-obstétricos.

Es muy importante distinguir entre la negligencia médica y el accidente que ocurre durante la atención médica y el tratamiento, sin que haya responsabilidad del médico:

- a) La negligencia médica comprende la falla del médico a la conformidad de las normas de la atención para el tratamiento de la condición del paciente, o falta de conocimiento, o negligencia al proporcionar la atención del paciente, que es la causa directa de un accidente al paciente.
- b) Un accidente producido durante un tratamiento médico, que no se pudo prever y que no fue el resultado de falta de conocimiento por parte del médico tratante, es un accidente desafortunado del cual el médico no es responsable.

La Asociación Médica Mundial propone, en la Declaración que hemos mencionado, que las leyes de cada nación deben prever los procedimientos necesarios a fin de establecer la responsabilidad de las demandas por negligencia médica y determinar la forma de resarcir el daño al paciente, en los casos en que se compruebe la negligencia.

El Sistema Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido tuvo como meta reducir el 40% de errores médicos para el año 2005, aprovechando el valioso conocimiento que se ha generado sobre el cómo y porqué se producen los casos de error médico, a través de estrategias tales como la estandarización de recetas computarizadas y la figura del auditor médico clínico.⁵⁶

F) MARCO JURÍDICO DE LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA EN MÉXICO.

En nuestro país, la atención médica es una actividad profesional fuertemente regulada, pues la doctrina jurídica la considera como depositaria de los “bienes” de mayor jerarquía que el Estado mexicano tutela: la salud y la vida.

Estos elementos normativos se encuentran definidos en la Ley Federal de Profesiones, en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Atención Médica, Reglamento en Materia de Protección Social en Salud, en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, NOM-034-SSA2-2002, para la prevención y control de los defectos al nacimiento, Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico, la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en materia de información en salud y en el caso de los profesionales de la salud que prestan servicios en instituciones dependientes del Gobierno Mexicano, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.⁵⁷ A partir del 13 de diciembre de 2012, la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico⁵⁸ sustituye a la NOM-168-SSA1-1998 e implementa nuevas obligaciones sobre el manejo, la conservación, la propiedad, la titularidad y la confidencialidad del expediente clínico.

Con las nuevas reformas a la Ley General de Salud, la atención materno-infantil sube a carácter prioritario en el área de Salud, con lo cual se abre el nuevo reto a las instituciones públicas y privadas en materia de salud para cumplir con la tarea de dar atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera; teniendo toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud.

Para el cumplimiento de esta normativa es necesario que se cumpla el artículo 64 bis de la Ley General de Salud (LGS):

“La Secretaría de Salud impulse la participación de los sectores social y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en materia de atención materno-infantil. Para tal efecto, promoverá la creación de Redes de Apoyo a la Salud Materno Infantil, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, con la finalidad de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas a información relativa a la prestación de servicios de atención médica en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos.”

Requisitos de los profesionales de la salud para la práctica de la obstetricia

- Título de médico cirujano o enfermera obstetra.
- Cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, o la Autoridad Educativa Local.
- Si los estudios se realizaron en el extranjero, revalidación por la Secretaría de Educación Pública, o la autoridad educativa local.

Requisitos de los establecimientos prestadores de servicios de salud para la atención obstétrica

Los establecimientos que prestan servicios de atención obstétrica, se encuentran regulados por la Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, el acuerdo por el que se establecen las bases para el desarrollo del Programa Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, el Reglamento Interno del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica y el Reglamento Interior de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica; con lo que en el año del 2009 se creó por el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica y la Comisión para la Certificación de Atención Médica además del “Manual del proceso para la certificación de hospitales”, instrumento clave para la certificación. En la NOM-197-SSA1-2000 se establecen los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, además en casos de atención a pacientes ambulatorios, se regula por la NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.

- Los establecimientos prestadores de servicios de salud facultados previamente por autorización de la Secretaría de Salud, serán las unidades de primer nivel con hospitalización, además de los hospitales generales, los hospitales de especialidades e institutos, públicos, privados o sociales.
- En la práctica obstétrica, será el responsable del establecimiento quien supervise la aplicación de la normatividad relacionada a la práctica de la obstetricia. Sólo podrá aplicarse con la participación del personal de salud competente y con el equipamiento mínimo indispensable.
- Los establecimientos prestadores de servicios de salud en donde se realiza la práctica obstétrica, deberán contar con el equipo mínimo obligatorio para la práctica en condiciones razonables de seguridad.
- Todo el equipo médico deberá estar sujeto a mantenimiento preventivo, correctivo y sustituido de acuerdo a los estándares obligatorios.

Responsabilidades de los prestadores de atención obstétrica

- Determinar el estado de salud y el índice de riesgo obstétrico de la paciente y valorar el requerimiento de otros especialistas para desarrollar un plan de cuidados obstétricos. Numeral 5.1.5 de la NOM-007-SSA2-1993, Artículo 62 y Artículo 64 de la LGS.
- Comunicar a la paciente, representante legal o familiar más cercano en vínculo, el plan propuesto y los riesgos inherentes al procedimiento. Artículos 29, 30 y 51 Bis 2 del Reglamento de atención médica de la LGS.
- Obtener la carta de consentimiento bajo información. Numeral 10.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.

- Indicar claramente la prescripción apropiada.
Numeral 5.1.2, 5.1.6, 5.7.4 de la NOM-007-SSA2-1993.
- Identificar a la paciente en la sala de labor y quirófano, confirmar el diagnóstico, el consentimiento informado, la cirugía propuesta y evaluar a la paciente durante todo su internamiento, con especial atención al trabajo de parto, de acuerdo con lo establecido en la NOM-007-1993.³¹
- Proporcionar a la paciente un trato respetuoso y digno de acuerdo a la ética médica, que engloba la identificación del personal que la atiende.
Artículo 51 y 83 de la LGS, Artículo 25 y 48 del RLGS en materia de atención médica.
- Realizar los procedimientos quirúrgicos con el personal y equipo médico necesarios.
Numeral 5.4.1.1, 5.4.5 de la NOM-007-SSA2-1993; 4.19, 6.3.1.3 de la NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
- Conducir personalmente la resolución del embarazo y permanecer en la sala de expulsión durante todo el procedimiento.
- Registrar completamente el proceso en el expediente, llenando adecuadamente el partograma como lo marca la norma y las necesidades específicas de cada paciente.
Numeral 4.15 NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
- Evaluar y verificar durante todo el trabajo de parto, ya que es un proceso dinámico.
Numeral 1 de la NOM-007-SSA2-1993.
- El obstetra se apoyará preferentemente con médicos especialistas para solucionar contingencias que se presenten durante la resolución del embarazo.
Numeral 5.1.1 de la NOM-007-SSA-1993, Artículo 55 de la LGS.
- En caso de relevo, el personal de salud deberá entregar a la paciente con el expediente donde se anoten detalladamente sus condiciones clínicas, y preferentemente, concluir todos los procedimientos que él mismo haya iniciado.
Numeral 5.1.1 de la NOM-007-SSA-1993 y numeral 9.5 de la NOM-040-SSA2-2004 en materia de información en salud.

Marco Jurídico de la Atención obstétrica por personal no profesionalizado

En 2001, para la certificación de las parteras empíricas que atienden aproximadamente uno de cada diez nacimientos en México, la Secretaría de Salud, a través del programa "Arranque parejo en la vida" (instrumento de la política nacional de salud con el que se busca contribuir al cumplimiento de dos de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que el Gobierno de México hizo suyos, junto con 189 países más, al adoptar la Declaración del Milenio en el año 2000), estableció coordinación con el IMSS, el IMSS-Solidaridad y el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), para la elaboración de una Norma de Competencia Laboral para Parteras, esto debido al porcentaje importante de partos atendidos por parteras tradicionales en el hogar en algunas entidades federativas del país.⁵⁸ En el 2004 se elaboró la Norma de Competencia Laboral y se instrumentó una estrategia que incluyó como elemento central la vinculación de la partera tradicional con las unidades de salud para la detección y referencia oportuna de mujeres con complicaciones obstétricas. Durante el periodo 2004-2006 se certificaron 1,247 parteras tradicionales.⁵⁹

Si bien es cierto que las parteras tradicionales o empíricas no se consideran profesionales por no encuadrar en los requisitos establecidos en nuestras leyes, son personal de salud de gran importancia para la atención de mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio debido al número de partos que éstas atienden, por lo que es fundamental delimitar sus principales funciones y tener una regulación sobre su campo de trabajo y las responsabilidades a que deban sujetarse, y al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación marca que al haber complicaciones o errores y resultar un homicidio debido a la labor de la partera, se tendrá por delito culposo aunque la actividad desplegada al atender en el alumbramiento a la parte lesionada, aunque esté ausente de dolo no excluye que el movimiento corporal de la partera quede comprendido dentro del delito culposo, si sin tener conocimientos técnicos para auxiliar a la parte lesionada, ni título expedido legalmente por autoridad competente, de acuerdo con la exigencia que crea la Ley Reglamentaria del Artículo 4o. Constitucional. De aquí la relevancia de regular la responsabilidad de las parteras tradicionales no sólo en el caso de homicidio, sino en los accidentes que tengan incidencia en la salud de la mujer y del recién nacido.

Al respecto el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Atención Médica contempla además al personal no profesional autorizado y son aquellas personas que reciban la capacitación correspondiente y cuenten con la autorización expedida por la Secretaría que los habilite a ejercer como tales, misma que deberá refrendarse cada dos años. Podrán prestar servicios de obstetricia y planificación familiar, además de otros que la Secretaría considere conveniente autorizar y que resulten de utilidad para la población. En obstetricia concretamente, podrán:

1. Atender los embarazos, partos y puerperios normales que ocurran en su comunidad, dando aviso a la Secretaría;
2. Prescribir los medicamentos que en esos casos se requieran de acuerdo a las Normas Técnicas que para dicho fin emita la Secretaría.

En el mismo Reglamento se establecen las obligaciones, prohibiciones y sanciones al personal no profesional autorizado en los artículos 111, 112 y 114 en su capítulo Quinto.

En materia internacional, rigen esta labor varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la

libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

II. ANÁLISIS DE LAS QUEJAS DE LA CONAMED

Ginecología y Obstetricia es una de las especialidades más frecuentes en las inconformidades recibidas en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. La frecuencia porcentual de estas inconformidades ha fluctuado entre el 17.5% y el 10.6% desde la creación de la Conamed en 1996. (Figura 5) Se revisaron las estadísticas institucionales del periodo Enero de 2002 a Septiembre de 2012, contabilizando 16947 asuntos atendidos. De ellas, 2272 estuvieron relacionadas con las especialidades de perinatología, ginecología y obstetricia.*

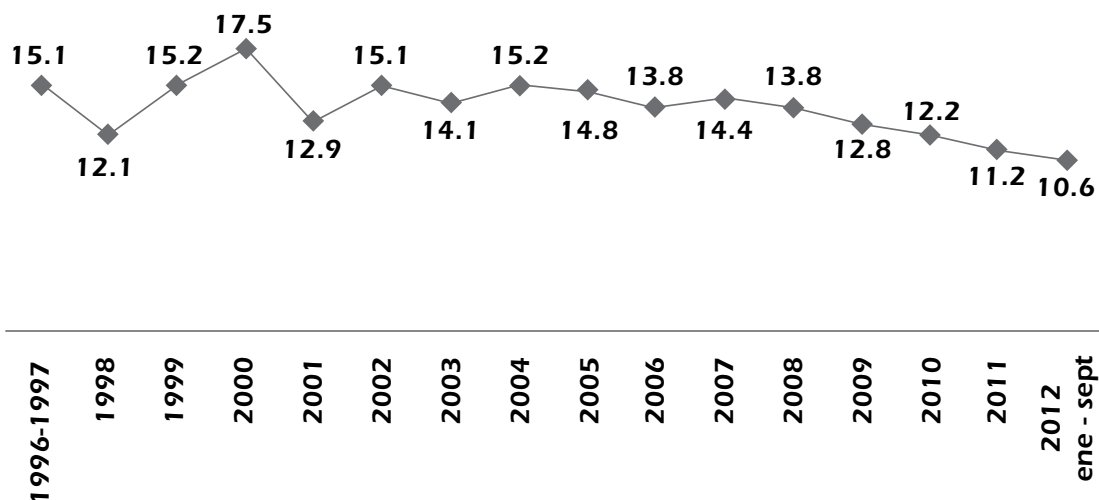


Figura 5. Distribución de la frecuencia de inconformidades presentadas ante CONAMED, relacionadas con Ginecología y Obstetricia en el periodo 1996-2012. Promedio 1996-2012: 13.8%.

Para el análisis general de estas inconformidades, se seleccionaron 848 casos correspondientes a pacientes obstétricas atendidas entre 1998 y 2011, para que las variables en estudio fueran comparables en todos los expedientes, ya que en años previos no estuvieron disponibles.

La mayor parte de los asuntos analizados en esta muestra correspondió a pacientes que fueron atendidas en instituciones del Distrito Federal (40.7%, 345 casos) o del Estado de México (23.8%, 202 casos). Las restantes 301 pacientes fueron atendidas en instituciones de diversos estados de la República Mexicana.

Las inconformidades se originaron, según el sector de servicios de atención médica, de la siguiente manera: instituciones de seguridad social 633 casos (74.6%), sector privado 109 casos (12.9%), sector público en 103 casos (12.1%) y en servicios de asistencia privada 3 casos (0.4%).

* CONAMED. Quejas concluidas por especialidad. Archivo estadístico correspondiente a cada año. Tema 4. Cuadro 13. [acceso] Disponible en: http://www.conamed.gob.mx/estadistica/index_2010.php?seccion=83.

Según el nivel de resolución de las instituciones de salud, 78.7% (667 casos) fueron atendidos en hospitales de 2º nivel, en tercer nivel 15.2% (129 casos) y en primer nivel 6.1% (52 casos). Ver Figura 6.

En 735 casos (86.7%), la inconformidad se refirió a la atención obstétrica y en 113 (13.3%) se relacionó con los resultados perinatales.

En 223 casos (26.3%), la inconformidad estaba dirigida a la institución o al servicio tratante, por lo que no se presentó documentación relacionada con el personal de salud involucrado en la atención; en 625 casos la inconformidad estuvo dirigida contra uno o varios profesionales de la salud (73.7%). De éstos, sólo se pudo evaluar la formación del profesional en 329 (52.6%) de los asuntos, ya que la documentación estuvo incompleta en 285 (45.6%) o incluso ausente en 11 (1.8%). De los 329 expedientes que sí incluyeron datos sobre la formación de los prestadores, en 128 (38.9%) fueron ginecoobstetras; en 84 (25.5%) eran médicos generales u otros especialistas; en 83 expedientes (25.2%) la inconformidad estuvo relacionada con médicos en formación (residentes, pasantes e internos de pregrado). En 34 casos (10.3%) no se pudo identificar la formación de los profesionales involucrados.

El promedio de edad de las embarazadas al momento de la atención médica fue de 25.4 años (DE 7.14 años), con la siguiente distribución por grupos etáreos: 15-24 años: 266 casos (31.4%), 25 a 34 años: 445 (52.5%), 35 a 44 años: 131 (15.4%), más de 45 años: 6 (0.7%).

Las pacientes se encontraban durante el tercer trimestre de gestación en 710 casos (83.7%), en el primer trimestre en 108 casos (12.7%), en el segundo trimestre 24 casos (2.8%) y los 6 casos restantes (0.8%) en el puerperio.

Los expedientes se encontraron incompletos en 474 asuntos (55.9%). Sólo en 384 casos (45.3%) se encontraron partogramas y notas de valoración obstétrica en 530 (62.5%), las historias clínicas y las notas de evolución estuvieron completas en 363 (48.0%) y 642 expedientes (75.7%) respectivamente; se entregaron notas de egreso en 638 (75.2%). Se realizaron intervenciones quirúrgicas (cesárea, histerectomía, etc.) en 316 casos (37.3%), pero sólo se documentó adecuadamente en 82 expedientes (9.7%), ya fuera por notas preoperatorias, dictado de operación, posoperatorias, preanestésicas o posanestésicas incompletas o ausentes. Se elaboraron cartas de consentimiento informado en 426 casos (50.2%), ya que 110 casos (34.8%) se realizaron más de una intervención quirúrgica.

En 524 expedientes (61.8%), las hojas de enfermería estuvieron completas.

La calificación de riesgo se documentó sólo en 320 (37.7%) de los casos: fue elevado en 265 pacientes (31.3%). Los antecedentes quirúrgicos previos representaron el factor de riesgo documentado más frecuente en 31.7% (84 casos), seguidos del embarazo complicado en 20.8% (55 casos) y las enfermedades preexistentes como hipertensión, diabetes y otras en 29 casos (10.9%) y otros factores de riesgo (97 casos, 36.6%).

Los tres diagnósticos de ingreso más frecuentes fueron: trabajo de parto a término en 14.5% (123 casos), desproporción cefalopélvica en 10.4% (88 casos) y pérdidas del primer trimestre de la

gestación en 9.2% (78 casos). Se registraron 12 ingresos con diagnóstico de cesárea electiva (1.4%).

Las complicaciones más frecuentes de los embarazos fueron puerperio patológico 64 (7.6%), sufrimiento fetal y/o asfixia perinatal 43 (5.1%), óbito fetal 34 (4.0%), embarazo ectópico 29 (3.4%) enfermedades hipertensivas (preeclampsia y eclampsia) 18 (2.1%) y hemorragias de origen placentario (desprendimiento prematuro, acretismo y placenta previa) 17 (2.0%).

Se atendieron 406 nacimientos por cesárea (46.9%; 8 fueron gemelares), 315 por parto (37.2%) y cinco mediante aplicación de fórceps (0.6%).

Las inconformidades ocurrieron durante la atención del parto en 354 casos (41.7%), durante el tratamiento quirúrgico 198 (23.3%), durante el tratamiento médico 83 (9.8%), durante el diagnóstico 65 (7.7%) y durante otros momentos de la atención obstétrica en 17 casos (2.0%). En 131 expedientes (15.4%) no se definió el momento durante el que se motivó la inconformidad. El 12.8% de las quejas (99 casos) fueron motivados por sugerencia directa de algún profesional de la salud.

En 468 expedientes (55.2%) se observaron problemas de comunicación en la relación médico-paciente-familiares.

En 187 casos (22.1%) se describieron daños de diversa magnitud a las pacientes o a los productos: de ellos, 31 (3.7%) fueron daños temporales, 62 (7.3%) permanentes y 94 (11.1%) muerte, las cuales corresponden a óbitos (4.0%) y 60 a muertes maternas (7.1%) directos en su totalidad. En 41 casos (4.8%) se explicitó que no se produjeron daños al binomio; en 523 (61.7%) no se documentó ningún dato relacionado a daños en el expediente.

En cuanto a desviaciones se observaron: atención inicial inadecuada en 119 casos (14.0%), seguimiento incompleto de la atención a la madre en 405 casos (47.8%), atención inadecuada del recién nacido en 210 casos (24.8%), diagnóstico incorrecto o incompleto en 201 casos (23.7%), errores quirúrgicos en 244 casos (28.8%), control subsecuente incompleto o inadecuado en 178 casos (21.0%), falta de detección oportuna de complicaciones 279 (32.9%), estudios paraclínicos incompletos o incorrectos 240 (28.3%), se documentó exceso terapéutico en 8 casos (0.9%).

La evaluación integral de los expedientes determinaron evidencia de mala práctica en 231 casos (27.2%), buena práctica en 525 casos (61.9%) y en 92 expedientes (10.8%), no hubo elementos para determinar.

Los usuarios presentaron entre 1 y 6 reclamaciones: las pretensiones fueron económicas en 782 casos (92.2%); solicitaron reembolso, condonación y/o reducción del adeudo en 309 casos (36.4%), indemnización, pago de daños y perjuicios y otros reclamos económicos 473 (55.8%); en 56 casos (6.6%) las pretensiones fueron únicamente recibir una explicación técnica-médica acerca de lo ocurrido; en 23 casos la pretensión fue que el personal de salud y/o institución recibieran una sanción; en los 103 expedientes no se consignó una pretensión clara en el dicho de queja inicial.

Los casos se resolvieron mediante acuerdo de conciliación 462 (54.5%), por laudo 3 (0.4%) y por amigable composición 1 caso (0.1%); en 233 casos (27.5%) se dejaron deudas a salvo por no lograrse la conciliación; 9 casos (1.0%) fueron improcedentes; 140 casos (16.5%) se concluyeron por falta de interés procesal.

De los 462 casos conciliados, en 200 (23.6%) el compromiso fue una transacción: indemnización en 110 casos (13.0%), reembolso de gastos o condonación de adeudo 65 casos (7.7%) atención médica especializada 25 casos (2.9%). En 256 casos (30.2%) se concilió mediante aclaración aceptada.

Se encontró evidencia de responsabilidad institucional en 68 expedientes (9.0%), todos los cuales fueron calificados como mala práctica.

Se utilizó la prueba chi cuadrada (χ^2) de Pearson, para comparar la distribución de frecuencias de los casos calificados como buena y mala práctica entre las diferentes variables analizadas. Se consideró una diferencia estadísticamente significativa cuando el valor de $p < 0.05$. Los datos se analizaron mediante el paquete estadístico PASW Statistical 18.®

Cuadro 9. Análisis de la distribución de buena y mala práctica con diferencias estadísticamente significativas.

VARIABLE	BUENA PRÁCTICA	MALA PRÁCTICA	p
Expediente clínico ▪ Suficiente	63.2%	26.1%	0.000
Modalidad de conclusión: conciliado ▪ Mediante transacción	6.9%	64.9%	0.000
Modalidad de conclusión: conciliado ▪ Mediante aclaración aceptada	42.7%	11.3%	0.000
Grado de daño ▪ Sin daño	35.6%	1.7%	0.000
Historia clínica ▪ Completa	37.0%	11.0%	0.000
Historia clínica ▪ Incompleta	17.7%	22.1%	0.000

En las variables restantes no se encontraron diferencias significativas.

III. DISCUSIÓN

“El siglo XX es testigo, desde sus inicios, de las constantes preocupaciones de los profesionales de la medicina dedicados a la práctica de la obstetricia clínica. En distintos puntos geográficos logran con su ingenio mejorar la salud de la mujer y su hijo; superan los procedimientos con que escasamente contaban para lograr resoluciones obstétricas cada vez más satisfactorias, resoluciones en las que mucho contaban las habilidades y las destrezas...”.¹⁶

Aunque autores como Valdés Salgado y Molina Leza refieren que las inconformidades son relativamente poco frecuentes porque nuestra población no ha adquirido la cultura para enfrentar a los médicos como figuras de autoridad, la tendencia reconocida en el mundo sobre la relación médico paciente, y declarada por autores como Smith, Stone y Pérez Tamayo,⁶¹⁻⁶³ es sobre el cambio en el modelo vertical y paternalista hacia una relación en que el médico es un prestador de servicios obligado a resultados óptimos y controlables.

Desde su creación en 1996, las estadísticas de CONAMED han mostrado a la ginecología y obstetricia como una de las dos especialidades más frecuentes en las inconformidades recibidas, con el 14.5% del total. Como en México se atienden al año más de un millón de partos y se realizan más de 500,000 cesáreas, resulta baja la incidencia de inconformidades, una por 10,000 embarazos resueltos; una por 275,000 partos atendidos y una por 270,000 cesáreas, por lo que autores como Saucedo,⁷⁵ atribuyen la aparición de inconformidades relacionadas a la atención proporcionada por los ginecoobstetras, a un problema probabilístico, relacionado con la gravedad de la paciente.

En nuestra revisión, la letalidad asociada a las inconformidades fue de 16.5%, debida a muertes obstétricas directas en el 15.7% de los casos, por lo cual vale la pena atender al concepto que menciona Lifshitz⁶⁴ sobre el manejo del “error latente”, previsiones que han permitido una reducción significativa de eventos adversos e indeseables en actividades de “alto riesgo”.

Casi tres cuartas partes (73%) de los casos procedieron del Distrito Federal o del Estado de México, probablemente debido a la elevada proporción de hospitales de concentración que se ubican en estas zonas. Más de dos terceras partes (72.1%) de las inconformidades se originaron en instituciones de seguridad social, lo que concuerda con los datos publicados en la Encuesta Nacional de Salud (1994),⁶⁵ se relaciona con la sobrepoblación de usuarios en las mismas y la disminución de los recursos destinados al sector salud, y es explicable porque dichas instituciones otorgan precisamente alrededor de dos terceras partes de las atenciones médicas que se brindan en el país.⁶⁶

Las inconformidades se originaron con mayor frecuencia durante el tercer trimestre de gestación (83.7%), seguidas del primero (12.7%) y segundo trimestres (2.8%). No existen estadísticas detalladas al respecto de cuál es el trimestre más afectado por complicaciones del embarazo, aunque es conocido que muchas gestantes, especialmente de zonas rurales, adolescentes y/o bajos ingresos, sólo acuden a atención médica para la resolución del embarazo; desde el enfoque psicosocial, existe un mayor apego de la madre y la familia hacia los productos próximos al término, pues, además de ser más cercano el esperado resultado favorable del embarazo, se percibe que existen más recursos médicos para resolver las complicaciones, que permiten no sólo la sobrevivencia, sino el bienestar del neonato, contrariamente a los embarazos tempranos,

de menor viabilidad. Esto es evidenciado porque los tres diagnósticos de ingreso más frecuentes fueron trabajo de parto a término (14.5%), desproporción cefalopélvica (10.4%) y pérdidas del primer trimestre de la gestación (9.2%).

Existe el registro de que en México, 2.5 millones de mujeres se embarazan al año, de las cuales, 370,000 partos (14.8%) son atendidos por personal no capacitado, y que 10.3% del total de nacimientos ocurren en la casa de las pacientes, atendidos por parteras.⁵⁶ Sin embargo, las atribuciones de la CONAMED sólo la facultan a dirimir controversias entre profesionales de la salud autorizados, por lo que no se analizó en la muestra ningún caso atendido por no-médicos. El 78.7% de los casos fueron atendidos en hospitales de 2º nivel, por médicos especialistas en ginecología y obstetricia en (38.9%) lo que se asocia evidentemente a las políticas de salud establecidas por las instituciones, con respecto de la atención hospitalaria de todos los nacimientos (en seguimiento al programa de OMS-UNICEF "Hospital Amigo del Niño y de la Madre" y de las unidades de atención de emergencia obstétrica -básicas e integrales-, recomendados por organismos internacionales).⁴⁸ En el tercer nivel se atendieron el 15.2% de las pacientes, y si recordamos que aproximadamente el 30% de los embarazos son de alto riesgo, nos encontramos que un número importante de embarazadas de alto riesgo (o *riesgo especial*) hayan sido atendidas en unidades médicas de menor complejidad a la requerida, lo cual es apoyado porque el 31.3% de los casos analizados correspondió a pacientes con calificación de riesgo elevado.

Estos resultados nos refuerzan, de manera clara, la necesidad y trascendencia de identificar los casos de riesgo especial, para derivarlos oportunamente a la unidad médica con el nivel de complejidad adecuado para resolver las complicaciones que se presentan en la atención obstétrica, que en nuestro grupo, fueron el sufrimiento fetal, óbito fetal (4.0%), y las hemorragias de origen placentario (2.0%), asfixia perinatal (5.1%).

El Instituto de Medicina de Estados Unidos (IOM) publicó en 2000 una estimación de que 98,000 muertes anuales ocurrieron en ese país por errores médicos, cifra que excede a otras causas muy importantes, como los accidentes en vehículos de motor, el cáncer de mama y la infección por VIH, lo que convertiría al error médico en un problema de salud pública. En nuestro país no existen estadísticas comparables; en nuestra muestra se identificaron errores médicos en 27.2% de los casos y se estableció buena práctica en casi dos terceras partes de los mismos (61.9%).⁶⁷

El mismo IOM publicó en 1999 que sólo uno de cada siete pacientes o familiares que han sufrido las consecuencias de un error médico interpone una acción legal, aunque no en todos los casos de inconformidad subyace una negligencia médica. González-Hermoso⁶⁸ en España, apunta que las repercusiones legales ocurren por equivocaciones diagnósticas en 75% de los casos, omisión de procedimientos en 77%, hechos ocurridos en urgencias en 70%, y 37.6% a motivos no operatorios. En México, Valdés, Campos y Saucedo señalan las complicaciones en el tratamiento y las intervenciones quirúrgicas como los momentos de la atención médica que originan inconformidades, con entre el 45% y 62%. Otros motivos de inconformidad descritos fueron la atención inoportuna (16%), los accidentes (15%) y la relación médico paciente inadecuada (15%). En nuestra serie, los motivos de inconformidad más importantes se relacionaron con la percepción de una atención deficiente o inadecuada durante el trabajo de parto (41.7%), durante el tratamiento quirúrgico (23.3%) y con la muerte del producto de la gestación en el 4.0% de los casos.

El resultado más notable de la atención obstétrica es el nacimiento, y según autores como Johnson⁶⁹ y Rubsamen,⁷⁰ los malos resultados médicos con praxis adecuada son, paradójicamente, los que generan el mayor número de demandas por mala práctica. En cerca de la mitad de los casos (46.9%) se atendió mediante operación cesárea, 37.2% por parto, y 0.6% con aplicación de fórceps. En el resto (9.2%), los productos no eran viables al momento de la terminación del embarazo. Las gestaciones analizadas tuvieron un desenlace desfavorable en 187 casos (22.1%), con muertes obstétricas en el 7.1% de los casos y morbilidad materna temporal o permanente en 11.0%. Los puerperios fueron patológicos en 7.4% de los casos.

Ward⁷¹ analizó 500 demandas por atención ginecoobstétrica, y encontró que 27% de ellas no eran defendibles, por haber quebrantado la Lex Artis médica, por fallas en la documentación o por ambas. El manejo que se dio a las pacientes de los casos analizados fue acorde a la Lex Artis médica vigente en la especialidad en 61.9% de los casos, y presentó desviaciones en 27.2%; principalmente por vigilancia deficiente del trabajo de parto en 47.8%, seguidas de diagnóstico erróneo (23.7%). El acto médico fue bien documentado en 44.1% de los casos, pero se encontraron deficiencias en el llenado del partograma (54.7%) y notas de valoración obstétrica (37.5) y en el expediente clínico en general en 90.3%.

En 2003, Fernando del Castillo y Cols., describieron deficiencias institucionales en 40.5% de los expedientes analizados, de las cuales la más frecuente fue la falta de equipo especializado en 8.3%, seguida de falta de disposición oportuna de hemoderivados, insuficiencia en ginecoobstetras y otro personal especializado y falta de supervisión a médicos en formación, con 6.6% cada rubro; en más de la mitad de los expedientes (59.5%), no se documentaron deficiencias institucionales. Aunque es cierto que las instituciones que cuentan con mayores recursos son capaces de brindar una mejor atención médica, existen evidencias de que el uso rutinario de algunos auxiliares diagnósticos como la cardiocotografía, básicos en las unidades tocoquirúrgicas y ampliamente recomendados por grupos promotores de la excelencia como el National Institute for Clinical Excellence en Londres, Inglaterra, no representaron una mejoría significativa en los resultados perinatales, ni en la incidencia de muertes fetales, asfixia perinatal, operación cesárea o parto instrumental. Sin embargo -concluye Impey, quien encabeza este grupo- es deber de todos los obstetras clínicos estar claramente enterados de los riesgos y complicaciones más frecuentes, para tomar las precauciones necesarias para reducir su aparición.⁷³ Otro grupo de investigadores clínicos, Goley y Kerney,⁷⁴ explica que los mejores obstetras y las mejores unidades perinatales se caracterizan por sus esfuerzos para mejorar su práctica profesional, examinando y aprendiendo de los errores que otros han cometido en el pasado.

En nuestra revisión, se documentaron problemas en la relación médico-paciente en 55.2% de los casos analizados. Una relación eficaz entre quien brinda atención a la salud y la paciente se basa en el conocimiento y la habilidad que capacitan al primero, en la comunicación eficaz entre las personas y en los estándares éticos que regulan el comportamiento de los participantes en la relación.⁷⁵ Se ha descrito que la comunicación deficiente entre médico y paciente, ya sea por sobrecarga de trabajo u otros factores, es una importante causa de desconfianza para los pacientes, que les predispondrá a atribuir cualquier evento adverso a un error del médico.

La eticidad es una cualidad de la atención médica que debe ser preservada. En el año 2002, se publicó el "Estatuto de profesionalismo para el nuevo milenio",⁷⁶ que podría sustituir al Juramento

hipocrático y la Declaración de Ginebra,⁷⁷ el cual propone como principio supremo, el bienestar del paciente y el respeto a su autonomía, y como compromisos de los médicos la competencia profesional, la honestidad con los pacientes, el mantener relaciones apropiadas con ellos y mejorar la calidad de la atención, entre otros. Sin embargo, aún prevalece el desconocimiento de los profesionales que atienden pacientes obstétricas acerca de las normativas legales tales como el derecho de la paciente y sus familiares a información suficiente, clara y veraz; el consentimiento válidamente informado, que implica, más allá de formatos firmados, las explicaciones e instrucciones pertinentes y necesarias.

Según lo revisado anteriormente, ante el complejo reto de la asistencia en el nacimiento de una nueva vida, se requieren acciones que trasciendan las limitaciones técnicas y económicas de las instituciones de salud, acciones sencillas al alcance de las habilidades y destrezas de cualquier profesional, para mejorar la salud de la mujer y su hijo: compromiso con los valores intrínsecos de la profesión médica, ser minucioso en la atención de las embarazadas, identificar los casos de riesgo especial, reconocer las limitaciones institucionales y propias, conocer los lineamientos éticos y normativos aplicables a la atención obstétrica, y retomar la esencia de la práctica médica: una buena comunicación en la relación médico-paciente, “una comunicación a nivel emocional y espiritual que... constituye una arma terapéutica poderosa y, muchas veces, imprescindible”.⁷⁸

IV. RECOMENDACIONES GENERALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA

1. EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO DEBEN SER ATENDIDOS POR PERSONAL CAPACITADO Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

- a) Otorgar la atención con los recursos humanos y materiales suficientes y adecuados.
- b) Todo embarazo de alto riesgo debe recibir atención especializada, en unidades con la capacidad de resolución adecuada.
- c) Utilizar las Guías Nacionales de Práctica Clínica (<http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/catalogoMaestroGPC.html>), los Lineamientos Técnicos relacionados y la normativa vigente en salud, en particular en Normas Oficiales Mexicanas NOM-007-SSA2-1993, *Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio* y NOM-004-SSA3-2012, *Del expediente clínico*, para la detección oportuna y prevención de las complicaciones del embarazo.
- d) Asegurar la actualización continua para mejorar el nivel de competencias profesionales.

2. VALORAR INTEGRALMENTE CADA CASO DURANTE LA ATENCIÓN PRENATAL E IDENTIFICAR LAS PACIENTES CON ALTO RIESGO.

- a) Valorar y documentar el riesgo reproductivo y obstétrico desde la consulta inicial, que debe incluir historia clínica y exploración COMPLETA, así como la búsqueda de violencia familiar.
- b) La valoración habitual durante cada consulta incluye:
 - i. Identificación de DATOS DE ALARMA.
 - ii. Valoración de molestias generales y estado de salud materno, alimentación y otros hábitos.
 - iii. Medición y registro de peso, presión arterial y cálculo de índice de masa corporal.
 - iv. Revaloración del riesgo obstétrico y perinatal.
 - v. Crecimiento uterino armónico y estado de salud del feto.
 - vi. Revisión e interpretación de resultados de estudios paraclínicos solicitados.
 - vii. Se debe prescribir hierro (sulfato o fumarato ferroso) y ácido fólico desde tres meses previos al embarazo y mantener el consumo durante toda la gestación.
- c) Solicitar los estudios de laboratorio que forman parte indispensable del Control Prenatal: Biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, VDRL, grupo sanguíneo y factor Rh y tamiz glucémico. Ofrecer a todas las pacientes la prueba para detectar el VIH, especialmente en pacientes con factores de riesgo.
- d) El ultrasonido es una herramienta útil y recomendable para valorar la evolución del embarazo, aunque no es indispensable.

- e) Prescribir toxoide tetánico y vacuna anti-influenza estacional a todas las pacientes, así como tratamiento con antibióticos seguros en todas las infecciones identificadas.
- f) Evitar el uso rutinario de las evaluaciones clínicas y estudios paraclínicos que no tengan justificación.
- g) Dar seguimiento a las variables clínicas de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente, para la detección temprana de las complicaciones más frecuentes y relevantes.

3. REDUCIR RIESGOS INNECESARIOS.

- a) Asegurar una atención obstétrica acorde a los riesgos establecidos. Los factores de riesgo más comunes durante el embarazo son:
 - i. Edad menor a 15 años o mayor a 40 años
 - ii. Obesidad
 - iii. Enfermedades crónicas: hipertensión, diabetes mellitus, cardiopatía, nefropatía, etc.
 - iv. Periodo intergenésico corto o cirugía uterina en los 18 meses previos
 - v. Multiparidad, 2 ó + abortos; 2 ó + cesáreas
 - vi. Enfermedades o complicaciones desarrolladas durante el embarazo actual: hipertensión gestacional, preeclampsia, diabetes gestacional, hemorragia obstétrica u otras pérdidas transvaginales, oligohidramnios o polihidramnios, restricción del crecimiento uterino, macrosomía, infecciones, alergias o cirugías durante el embarazo.
 - vii. Factor sanguíneo RH negativo
 - viii. Anemia con hemoglobina menor a 10 g/dL.
 - ix. Nivel sociocultural bajo, no unida, sin red personal de apoyo.
- b) Conducir y supervisar la atención obstétrica, especialmente cuando participe personal en formación.
- c) Valorar cada caso en particular y revalorar cada momento específico de la gestación. Tener siempre presente que algunos factores de riesgo PUEDEN CAMBIAR en el transcurso del embarazo, si una complicación se resuelve o si se desarrollan nuevas patologías.

4. ESTRECHAR LA VIGILANCIA PRENATAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN.

- a) Citar a las pacientes a revisión cuantas veces la clínica lo indique necesario.
- b) Búsqueda intencionada de datos que sugieran actividad uterina, infecciones genitourinarias, hipertensión, proteinuria, diabetes gestacional, restricción del crecimiento intrauterino o alteraciones de la motilidad fetal.
- c) Dar consejería personalizada sobre lactancia materna y anticoncepción post-evento obstétrico (APEO).

5. PROCURAR LA MEJOR ATENCIÓN OBSTÉTRICA.

- a) Detectar oportunamente los casos que requieran manejo por especialidad o un mayor nivel de capacidad resolutive.
- b) Elaborar el partograma de manera completa y adecuada, para la correcta interpretación de la curva de Friedman.
- c) Derivar oportunamente al nivel de atención adecuado para la resolución del embarazo según el riesgo identificado.
- d) En caso de una urgencia (o emergencia) obstétrica real, cualquier institución, incluso privada, está obligada a dar atención a una paciente, hasta su estabilización clínica.
- e) Utilizar el **Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas**, el cual permite que las mujeres que presentan una emergencia durante el embarazo, el parto o la cuarentena, sean atendidas gratuitamente en la Secretaría de Salud, el IMSS o el ISSSTE, sin importar su régimen de derechohabiencia. La protección incluye la atención de los neonatos.
- f) Contar o disponer del equipo necesario para la vigilancia y traslado oportuno.

6. ESTABLECER EL MEJOR PLAN DE NACIMIENTO.

- a) Elegir cuidadosamente la vía de nacimiento más apropiada, parto o cesárea, de acuerdo al estado clínico del binomio.
- b) Limitar lo razonablemente posible, la realización de la primera cesárea, así como la cesárea electiva.
- c) Realizar una vigilancia clínica adecuada del trabajo de parto para identificar complicaciones de manera oportuna.
- d) Contar con el consentimiento válidamente informado, cuando así lo amerite.

7. VIGILAR ESTRECHAMENTE A LA PACIENTE DURANTE EL PUERPERIO INMEDIATO.

- a) Revalorar el estado clínico de la paciente, documentando sus condiciones, así como las indicaciones, de acuerdo a lo señalado por las Normas Oficiales Mexicanas vigentes.
- b) Considerar especialmente el estado mental, coloración tegumentaria, tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, temperatura, estado de hidratación, así como hemorragia transvaginal o de la herida quirúrgica, dolor pélvico, vaginal o perineal, y la función de emuntorios.
- c) Pasar visita a todas las pacientes púerperas, aún en los puerperios de bajo riesgo y, posteriormente las veces que sea necesario.
- d) Realizar una exploración ginecológica completa al momento del egreso.
- e) Asegurar la comunicación adecuada entre el médico y la paciente.
- f) Fomentar el alojamiento conjunto, lactancia materna y APEO en todas las pacientes púerperas.

8. DOCUMENTAR TODO EL PROCESO DE ATENCIÓN.

- a) Documentar debidamente el evento obstétrico en el expediente clínico: nota de valoración inicial, triage, partograma, nota prequirúrgica y postquirúrgica con el nombre completo y firma del médico o los médicos que participaron en la atención de la paciente.
- b) Anotar en el expediente clínico el razonamiento clínico que sustente los procedimientos a realizar durante toda atención obstétrica.

9. REALIZAR, PROMOVER Y FACILITAR LA EDUCACIÓN A LA EMBARAZADA Y SUS FAMILIARES SOBRE LOS RIESGOS INHERENTES A LA GESTACIÓN.

- a) Elaborar junto con la paciente y su familiar, el Plan de Seguridad Obstétrica, desde la primera consulta; revisarlo en cada consulta para hacer las adecuaciones necesarias.
- b) Explicar desde la primera consulta cuáles son los riesgos generales y específicos del embarazo para cada paciente en particular y documentarlo en el expediente.
- c) Enfatizar sobre los datos de alarma y la conducta recomendada para cada uno, durante todas y cada una de las consultas prenatales.
- d) Explicar de manera sencilla lo que puede ocurrir en la sala de labor, expulsión y quirófano, para tranquilizar a la paciente y sus familiares.
- e) Favorecer y estimular la educación para la salud a la embarazada por el grupo multidisciplinario que tiene contacto con las pacientes durante la atención obstétrica.
- f) La información deberá explicarse a la paciente y al familiar responsable que ella designe.

**RECOMENDACIONES PARA LA INDICACIÓN Y USO SEGUROS DE
OXITOCINA EN OBSTETRICIA**

1. El uso de oxitocina en la atención obstétrica deberá basado en la evaluación individualizada de cada paciente y adecuadamente justificado en el razonamiento clínico

- a) Restringir la indicación de oxitocina a los casos y momentos en que exista una justificación clínicamente bien razonada para su uso.
- b) Identificar los factores de riesgo del binomio madre-hijo para el uso de oxitocina, tales como cesárea anterior, sobredistensión uterina (embarazo gemelar, polihidramnios, gran multiparidad y macrosomía).
- c) Utilizar los criterios establecidos para el uso de oxitocina en los Lineamientos Técnicos oficiales, en las Guías Nacionales de Práctica Clínica y en la normativa vigente en salud, en particular en Normas Oficiales Mexicanas NOM-007-SSA2-1993, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio y NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.

2. Valorar integral y continuamente a la paciente y al feto durante todo el proceso de atención.

- a) Dar seguimiento a las variables clínicas de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente, para la detección temprana de las complicaciones más frecuentes y relevantes.
 - Evaluar y documentar la frecuencia cardíaca fetal cada 15 minutos.
 - Vigilar continuamente la frecuencia, intensidad y efectividad de la actividad uterina.
 - Medir el borramiento y dilatación cervicales de manera regular al menos cada 4 horas durante la fase latente de trabajo de parto y al menos cada hora durante la fase activa; la frecuencia de valoración puede aumentar conforme al criterio clínico.
- b) En el caso de una urgencia (o emergencia) obstétrica real, utilizar el Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas, para que sean atendidas en la Secretaría de Salud, el IMSS o el ISSSTE, sin importar si son o no derechohabientes.
- c) Tener siempre presente que las EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS PUEDEN PRESENTARSE EN CUALQUIER MOMENTO en el transcurso del trabajo de parto, por lo que el seguimiento clínico deberá ser CONTINUO.
- d) Detectar oportunamente los casos de emergencia obstétrica y derivar de inmediato a las pacientes que requieran manejo por especialidad o un mayor nivel de capacidad resolutive. Contar o disponer del equipo necesario para la vigilancia y traslado oportuno.

3. Documentar toda la atención obstétrica.

- a) Documentar debidamente el evento obstétrico en el expediente clínico y anotar siempre el nombre completo y firma de todos los profesionales de la salud que participaron en la atención de la paciente.
- b) Anotar claramente en el expediente clínico el razonamiento clínico que sustente la indicación del uso de oxitocina durante la atención obstétrica.
- c) Señalar claramente la dosificación del medicamento, verificando los Cinco Correctos: paciente, medicamento, vía, dosis y duración.
- d) Documentar los factores de riesgo del binomio.
- e) Elaborar el partograma de manera completa y adecuada, para la correcta interpretación de la curva de Friedman.

4. Mantener una comunicación continua con la embarazada y sus familiares durante toda la atención obstétrica.

- a) Explicar desde el primer contacto con la paciente, de manera sencilla, lo que puede ocurrir en la sala de labor, expulsión y quirófano.
- b) Mantener comunicación constante con la paciente y su familiar, informando sobre diagnóstico, manejo establecido, evolución y pronóstico del binomio.
- c) Recordar que la información es indispensable para tranquilizar a la paciente y su familiar.

V. REFERENCIAS

1. Cunningham FG, MacDonald PC, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC, Hanks GDV, Clark SL. *Obstetricia de Williams*. 20ª ed. Buenos Aires: Edit. Médica Panamericana; 1998.
2. De Miguel JR, Fabre E. Etiología de la mortalidad perinatal. En: *Gynécologie 5200-A-05*. Encycl Med Chir. París: Elsevier; 1998. p: 1-4.
3. Espinoza de los Reyes VM, Azcárate Sánchez Santos S. Antecedentes Históricos. En: Cerna Rodríguez JA (coordinador). *Vigilancia Prenatal. Programa de Actualización Continua para el Ginecoobstetra. PAC-GO-1. Libro 1 Obstetricia*. México: Edit. Intersistemas; 1998. p.7.
4. Infante-Castañeda C. Quejas médicas. México: ETM; 2006. 211 p.
5. Noguera-Sánchez MF, García-Kavanagh R, Cruz-Rojas RE. La queja médica derivada de la atención en ginecoobstetricia. *Ginecol Obstet Mex*. 2010; 78 (5): 281-6.
6. Fajardo-Dolci GE, Hernández-Torres F, Santacruz-Varela J, Hernández-Ávila M, Kuri-Morales P, Gómez-Bernal E. Perfil epidemiológico general de las quejas médicas atendidas en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 1996-2007. *Salud Publica Mex*. 2009; 51 (2): 119-125.
7. Secretaría de Salud (México). Egresos por especialidad. Servicios hospitalarios por tipo según entidad federativa, 2008. Base de datos [acceso 30-10-2012]. Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx/descargas/zip/bie28_vIII.zip.
8. Secretaría de Salud (México). Egresos hospitalarios registrados en las unidades médicas de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud, 2011. Base de datos [acceso 24-10-2012]. Disponible en: <http://www.sinais.salud.gob.mx/egresoshospitalarios/basesdedatoseh.html>.
9. Secretaría de Salud (México). Estadísticas de Salud 2000. *Salud Pub Mex*. 2001;43(5):494-510.
10. Rosenfield A, Fathalla MF. *Manual de Reproducción Humana de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)*. New York: Parthenon Publishing Group; 1994. p. 337-345, 403-419. [Colaboración FIGO-OMS-Center for Population and Family Health, Columbia University]
11. Tsui AO, Wasserheit JN, Haaga JG (editores). *Healthy Pregnancy and Childbearing*. En: *Reproductive Health in Developing Countries: Expanding Dimensions, Building Solutions*. Washington (US): National Academy Press; 1997.
12. Chalmers B, Mangiaterra V, Porter R. WHO Principles of Perinatal Care: The Essential Antenatal, Perinatal and Postpartum Care Course. *Birth*. 2001; 28 (3): 202-207.
13. Arias F. Guía práctica para el embarazo y el parto de alto riesgo. 2a ed. Mosby-Doyma Libros; 1993. p 3-5. Madrid, España, 1993:3-5.
14. Martin MC. Acercamiento a la paciente. En: De Cherney AH, Pernoll MK. *Diagnóstico y Tratamiento ginecoobstétricos*. 7ª ed. México: Manual Moderno; 1999. p. 3-6.
15. CENETEC. Supervisión del embarazo normal. Guía de práctica clínica para el control prenatal con enfoque de riesgo. México: Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica IMSS-028-08. [acceso 31-10-2012] Disponible en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/028_GPC__PrenatalRiesgo/IMSS_028_08_GRR.pdf.
16. Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención medica especializada. *Diario Oficial de la Federación*, 17 de abril de 2000.
17. Norma Oficial Mexicana NOM-178-SSA1-1998, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención medica de pacientes

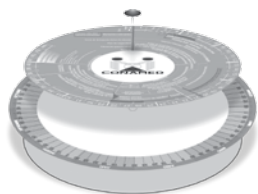
- ambulatorios. Diario Oficial de la Federación, 14 de diciembre de 1998.
18. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. México: Diario Oficial de la Federación; 31 de octubre de 1994.
 19. Conamed. Herramientas para el cuidado prenatal seguro. Disponible en: <http://www.conamed.gob.mx/gestograma.html>.
 20. Freyermuth G, Meléndez D, Meneses S. Plan de Seguridad: un modelo de diseño y puesta en marcha de acciones para disminuir la muerte materna. *Rev Mujer y Salud* (Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe). 2008; 4:76-80. En: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/resource/coneval/info_public/Estrategia%20Integral.pdf?view=true.
 21. Chávez AV, Gaña EB. Valoración del riesgo reproductivo en mujeres que trabajan. *Rev Med IMSS* 1993; 31: 119-21.
 22. Dirección General de Salud Reproductiva. Enfoque de riesgo reproductivo. Disponible en: URL: <http://cenids.insp.mx/dgsr/prenatal/riesgo-2.htm>
 23. Sokol RJ; Larsen JW; Landy HJ; Pernoll ML. Métodos de valoración para el embarazo con riesgo. En: Pernoll ML. Diagnóstico y tratamiento ginecoobstétricos. 6ª edición. Ed. El Manual moderno. México: 1993. p:313-50.
 24. Ahued-Ahued JR, Fernández del Castillo SC, Bailón NR. Ginecología y Obstetricia aplicadas. 2ª edición. Editorial Manual Moderno. México: 2003. Capítulo 55. p:569. ISBN 970-729-009-9.
 25. Arias F. Guía Práctica para el embarazo y parto de alto riesgo. 2ª edición. Madrid, Mosby Doyma: 1995.
 26. Alamia V Jr, Meyer BA. Peripartum hemorrhage. *Obstet Gynecol Clin North Am.* 1999;26(2):385-98.
 27. Ahued Ahued JR, Quesnel García-Benítez C, Simon Pereira LA. Parto y Cesárea. Programa de Actualización Continua para el Ginecoobstetra. Programa de Actualización Continua para el Ginecoobstetra. PAC-GO-1. Libro 3 Obstetricia. Primera edición. Edit. Intersistemas. México: 1998.
 28. Grupo de Trabajo Interagencial Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna. Consulta Técnica Regional: "Atención Calificada del Parto en América Latina y el Caribe". Informe 2004. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: PAHO; 9-11 de junio de 2003. [acceso 12-11-2012] Disponible en: <http://www.paho.org/Spanish/AD/FCH/WM/Atencioncalificadadelpartoinformefinal.pdf>.
 29. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Estrategia Regional para la Reducción de la Mortalidad y Morbilidad Maternas. Washington: OPS/OMS; 2002.
 30. Family Care International. La atención calificada durante el parto. Un cuaderno informativo. Nueva York: FCI: 2003. [acceso 12-11-12] Disponible en: <http://www.familycareintl.org/UserFiles/File/Skilled%20Care%20Info%20Kit%20PDFs/Spanish/spanish%20info%20book.pdf>.
 31. Secretaría de Salud (México). Programa de Acción Específico: "Arranque parejo en la vida". 2007-2012. Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud. México:2007.
 32. Carrasco-Cortez V, Lozano-Salazar E, Velásquez Pancca E. Análisis actual y prospectivo de la oferta y demanda de médicos en el Perú 2005 – 2011. *Acta Med Per.* 2008; 25(1): 22-9.

33. SINAIS (México). Boletín de Información Estadística No. 31, 2011. [acceso 12-11-12] Disponible en: http://www.sinais.salud.gob.mx/descargas/zip/bie31_vl.zip.
34. Chalmers B, Mangiaterra V, Porter R. WHO principles of perinatal care: the essential antenatal, perinatal, and postpartum care course. *Birth* 2001; 28: 202-207.
35. Atención humanizada del parto y nacimiento. Por un parto amoroso, libre, consciente y seguro. México: Nueve Lunas, S.C; SIN FECHA. [acceso 10-11-12] Disponible en: <http://nuevelunas.org.mx/PARTOHUMANIZADO.pdf>.
36. Den Hertog CEC, De Grot ANJA, van Dongen PWJ. Historia de la oxitocina. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* (Ed. Española). 2001; 1: 315-319. [acceso 21-11-2012] Disponible en: <http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/publicaciones/europeangynecol4/315-319.pdf>
37. Bugg G, Siddiqui F, Thornton J. Oxitocina versus ningún tratamiento o tratamiento tardío para la evolución lenta durante el período de dilatación del trabajo de parto espontáneo. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2011 Issue 7. Art. No.: CD007123. DOI: 10.1002/14651858.CD007123. [acceso 21-11-12] Disponible en: <http://www.update-software.com/PDF-ES/CD007123.pdf>.
38. Protocolo de inducción del parto y maduración cervical. Servicio de Medicina Materno-Fetal. Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia, Hospital Clínic de Barcelona. [acceso 21-11-2012] Disponible en: http://www.medicinafetalbarcelona.org/clinica/images/protocolos/obstetricia/INDUCCION_DEL_PARTO.pdf.
39. Fabre González E. Mortalidad perinatal. *Encycl Méd Chir* 1997; 5110(A):15.
40. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (México). Anuario Estadístico 2000. Disponible en: URL: http://www.ssa.gob.mx/apps/htdocs/estadisticas/b_datos/b_datos.htm.
41. Organización Mundial de la Salud. Mortalidad materna. Nota descriptiva N°348. Ginebra: WHO; mayo 2012. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/>.
42. INEGI. Hombres y mujeres en 2011. [acceso 9-11-2012] Disponible en: <http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/MyH2011.pdf>.
43. Freyermuth-Enciso G. Desiguales en la vida, desiguales para morir. La mortalidad materna en Chiapas: un análisis desde la inequidad. Informe sobre Desarrollo Humano en Chiapas. Documento de Trabajo 2010 / 1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano en Chiapas. Documentos de Trabajo 2010 Mayo 2010. [acceso 9-11-2012] Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/resource/coneval/info_public/Estudios_relacionados/MMChs_19dejulio_GFE_VF_conGraficas.pdf?view=true.
44. Organización Mundial de la Salud. Estadísticas sanitarias mundiales 2012. [acceso 9/11/2012] Disponible en: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/ES_WHS2012_Full.pdf.
45. SINAVE. Informe semanal de Vigilancia Epidemiológica, Semana 045, actualizada 7-12-2012. [acceso 18-12-2012] Disponible en: <http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Boletines%2045.pdf>.
46. SINAIS. Muertes maternas. [acceso 10-11-12] Disponible en: <http://sinais.salud.gob.mx/muertesmaternas/index.html>
47. Ruíz Moreno JA. Mortalidad materna en el Hospital Central Militar. Reporte de 25 años (1968-1991). *Ginecol Obstet Mex* Nov 1995;63:452-459.
48. Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia

- Obstétrica. [acceso 03-12-2012] Disponible en: http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/ceo_conv.pdf.
49. Purdon TF, MacLennan A. ACOG Calls for Immediate Reform in Liability Insurance. *Med J Aust* 2002;176:425-428.
 50. Lynch CB, Coker A, Dua JA. A clinical analysis of 500 medico-legal claims evaluating the causes and assessing the potential benefit of alternative dispute resolution. *Br J Obstet Gynaecol* Dec 1996; 103:1236-1242.
 51. Informes Anuales de Actividades, Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 1996-2011.
 52. Saucedo-González LF, Tinoco-Jaramillo G, Morales-Ramírez JJ. Demandas contra ginecoobstetras en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. *Ginecol Obstet Mex* dic 2001;69(12):487-491.
 53. Valdés-Salgado R, Molina-Leza J, Solís-Torres C. Aprender de lo sucedido. Análisis de las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. *Salud Publica Mex* 2001;43(5):444-454.
 54. Campos-Castolo EM, Valle-González A. Análisis de veinticinco casos de controversias por atención ginecoobstétrica ante la CONAMED. *Ginec Obst Mex* 2001;69:57-64.
 55. Morales-Ramírez JJ, Saucedo-González LF. La mayoría de las quejas por atención ginecológica y obstétrica se generan por percepciones derivadas de resultados inevitables. *Ginec Obstet Mex* 2001;69:108-117.
 56. Dean B, Schachter M, Vincent C, Barber N. Prescribing errors in hospital inpatients: their incidence and clinical significance. *Qual Saf Health Care* 2002;11:340-4.
 57. CONAMED. Normas Oficiales Mexicanas de interés para los médicos. [acceso 18-12-2012] Disponible en: http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/normas.php?seccion=82.
 58. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM- 004-SSA3-2012, Del expediente clínico. México: Diario Oficial de la Federación; 15 de octubre de 2012. [acceso 18-12-2012] Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fecha=15/10/2012.
 59. Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación (México). 26 de mayo de 1945. 7ª edición. Editorial PAC. México: 1996.
 60. Ley General de Salud. Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación (México). Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de junio del año 2012.
 61. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. Diario Oficial de la Federación (México). 29 de abril de 1986.
 62. Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002, para la prevención y control de los defectos al nacimiento. Disponible en: <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/034ssa202.html>. Diario Oficial de la Federación (México), 28 de febrero de 2003.
 63. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Diario Oficial de la Federación (México). 13 de marzo de 2002.
 64. Secretaría De Salud. "Programa De Acción Específico 2007-2012: Arranque Parejo En la Vida". Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Web. 4 Feb. 2012.
 65. Suprema Corte De Justicia De La Nación. "Parteras sin título", tesis aislada 295049 IUS. Seminario Judicial de la Federación. Web. 15 Feb. 2012
 66. CONAMED. Quejas concluidas por especialidad. Archivo estadístico correspondiente a cada año. Tema 4. Cuadro 13. [acceso] Disponible en: http://www.conamed.gob.mx/estadistica/index_2010.php?seccion=83.

67. Stone T, Mantese A. Conflicting values and the patient provider relationship in managed care. *J Health Care Finance* 1999;26(1):48-62.
68. Pérez Tamayo R. La estructura de la práctica médica actual. En: Rivero-Serrano O (coord). *El ejercicio actual de la medicina*. Siglo XXI editores. México 2000.
69. Smith R. Why are doctors so unhappy? *BMJ* 5 May 2001;322:1073-4.
70. Lifshitz A. El significado actual de "primum non nocere". Seminario sobre el Ejercicio Actual de la Medicina. Facultad de Medicina. Disponible en: URL: http://www.facmed.unam.mx/eventos/seam2k1/junio_2k2.pdf.
71. Ramírez Sánchez TJ, Nájera Aguilar P, Nigenda López G. Percepción de la calidad de la atención en los servicios de salud en México: perspectiva de los usuarios. *Salud Pub Mex*. 1998;40(1):3-12.
72. Secretaría de Salud (México). Programa Nacional de Salud 2001-2006. La democratización de la salud en México: Hacia un sistema universal de salud. 2ª edición. México: julio 2001.
73. Institute of Medicine (USA). Disponible en: URL: <http://www.iom.edu>.
74. González Hermoso F. Errores médicos o desviaciones en la práctica asistencial diaria. *Cir Esp* 2001;69:591-603.
75. Johnson KD. Malpractice in Obstetrics. *Int J Gyn Obstet* Sept 15 2001;2530(8):4391-4455. Disponible en: URL: <http://www.medical-library.org/index.htm>.
76. Rubsamen DS. Doctors and Malpractice: Some Parting Thoughts. *Phys Finan News* 2002;20(4):22-24. Comentado en: *Medscape Reviews* 2002. Disponible en: <http://www.medscape.com/viewarticle/430642>.
77. Ward CJ. Analysis of 500 malpractice claims: Causes and Prevention. *Am J Obstet Gynecol* 1991;165:298-306.
78. Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico. Diario Oficial de la Federación (México), 14 de septiembre de 1999.
79. Impey L, Reynolds M, MacQuillan K, Gates S, Murphy SO. Admission cardiotocography: a randomised controlled trial. *Lancet* 2003; 361: 465-70.
80. Goley RB, Kearney P. Malpractice losses in obstetrics. A review of claims. *N J Med* 2002;99(12):7.
81. Scott JR, Di Saia PJ, Hammond CB, Spellacy WN. Tratado de Obstetricia y Ginecología de Danforth. Editorial Médica Panamericana. 8ª ed. México;2000.
82. American Board of Internal Medicine, American College of Physicians, American Society of Internal Medicine, European Association of Internal Medicine. Medical professionalism in the New Millenium: a Physician Charter. *Ann Intern Med* 2002;136:243-246.
83. Declaración de Ginebra. 2ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial de Ginebra, Suiza, septiembre 1948, y enmendada por la 22ª Asamblea Médica Mundial de Sydney, Australia, agosto 1986 y la 35ª Asamblea Médica Mundial de Venecia, Italia, octubre 1983, y la 46ª Asamblea General de la AMM de Estocolmo, Suecia, septiembre 1994.
84. Jinich H. El paciente y su médico. Primera edición. UNAM-JGH editores. México:1997. p:82.

ANEXO I



COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN GESTOGRAMA PARA EL CONTROL PRENATAL SEGURO



INTRODUCCIÓN

Un gestograma, calendario obstétrico o disco prenatal, es una herramienta del control prenatal, cuya función básica es auxiliar al profesional de la salud, en el cálculo de la edad gestacional y la fecha probable de parto de una paciente embarazada, a partir de la fecha de la última menstruación. También es útil para calcular edad gestacional traspolada, en las embarazadas con amenorrea no confiable, de una manera sencilla, a partir de ultrasonogramas obstétricos.

Este gestograma agrega otros rubros de interés y utilidad para el profesional de la salud, basados en documentos normativos que representan la lex artis de la atención a la mujer embarazada en México, organizados por consulta y edad gestacional, para que el profesional de la salud se oriente acerca de los cuidados mínimos indispensables a realizar en el momento de la gestación en que se da el encuentro con la paciente embarazada.

DESCRIPCIÓN DEL GESTOGRAMA

Presenta un disco central con doble cara, que marca los meses y los días y dos discos internos, uno por lado, que incluyen las consultas mínimas recomendadas y diversos cuidados, acciones de salud y datos de referencia para el control prenatal.

Los datos registrados en los discos internos de esta herramienta son:

Disco 1 (anverso), incluye un logo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en el centro del mismo. Ver página 14.

- **Semanas.** Se refiere a las semanas de gestación e identifica desde el primer día del último periodo menstrual o Fecha de Última Menstruación (FUM), hasta la semana 44.
Mes. Establece meses lunares (1 mes = 4 semanas), a partir de la FUM.
- **Momentos relevantes.** Señala periodos con relevancia clínica o médico-legal que guían el actuar del profesional de la salud durante la atención obstétrica.
- **Inicio de búsqueda (de) datos de alarma.** Conforme a la evolución del embarazo, existen diversos riesgos para el binomio madre-feto, por lo que se señala el momento en que se debe comenzar a buscar, de manera intencionada, la presencia del dato de alarma señalado. Los datos de alarma son sumativos durante la gestación y debe documentarse en el expediente clínico, el resultado de la búsqueda intencionada, sea positiva (se encontró el dato de alarma) o negativa (no se encontró el dato de alarma).
- **Plan de seguridad.** Es una herramienta derivada del programa sectorial “Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México”, que busca orientar y educar a la embarazada y a su familia cercana, a través de la reducción de riesgos, la identificación temprana de datos de alarma y la planeación de acciones que permitan reducir la emergencia obstétrica.
- **Educación para la salud.** Recomienda temas a tratar con la

embarazada durante las consultas, establecidos en las normas oficiales mexicanas.

- **Producto.** Orienta al profesional de la salud sobre la denominación científica apropiada del producto de la concepción, de acuerdo a su evolución.

Disco 2 (reverso). Al centro del disco describe la Valoración mínima durante cada consulta que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993. Ver página 15.

- **Consultas mínimas.** En el numeral 5.2.3, la NOM 007 establece que la unidad de salud debe promover que la embarazada de bajo riesgo reciba como mínimo cinco consultas prenatales, iniciando preferentemente en las primeras 12 semanas de gestación y atendiendo al calendario que se señala en el gestograma.
- **Consultas recomendables.** Recomendaciones internacionales sobre frecuencia y acciones de salud básicas a realizar durante el control prenatal.
- **Cuidado prenatal mínimo.** En el numeral 5.1.6, la NOM 007 establece las actividades mínimas que se deben realizar durante el control prenatal.
- **Crecimiento uterino (cms) desde borde de sínfisis púbica.** (percentila 50). Evolución del crecimiento uterino promedio, equivalente a la percentila 50 según curvas de crecimiento, a través de la medición clínica realizada desde el borde de la sínfisis del pubis (BSP).
- **Incremento ponderal.** Modificación en el peso, a partir del peso real de la mujer antes del embarazo. Valores promedio en kilogramos, equivalentes a la percentila 50 según curvas de crecimiento.
- **Paraclínicos.** Estudios paraclínicos mínimos recomendados durante el control prenatal, incluye los establecidos en el numeral 5.1.6 de la NOM 007, en la Guía de Práctica Clínica para el control prenatal con enfoque de riesgo y en diversas publicaciones normativas.

FORMA DE USO

Se utiliza haciendo coincidir la gran línea roja marcada como Primer día del último periodo con la fecha real de la paciente embarazada, para después identificar la fecha-calendario del día en que se está otorgando la consulta. Se deben consultar ambos discos para observar en qué momento de la gestación se encuentra la paciente, cuáles son los datos clínicos y paraclínicos a evaluar, los datos de alarma que deben descartarse, así como las acciones del Plan de Seguridad Obstétrica y educación para la salud que corresponden a la consulta actual.

Ejemplo: La FUM de la paciente fue el 31 de diciembre y la fecha actual es 10 de marzo.

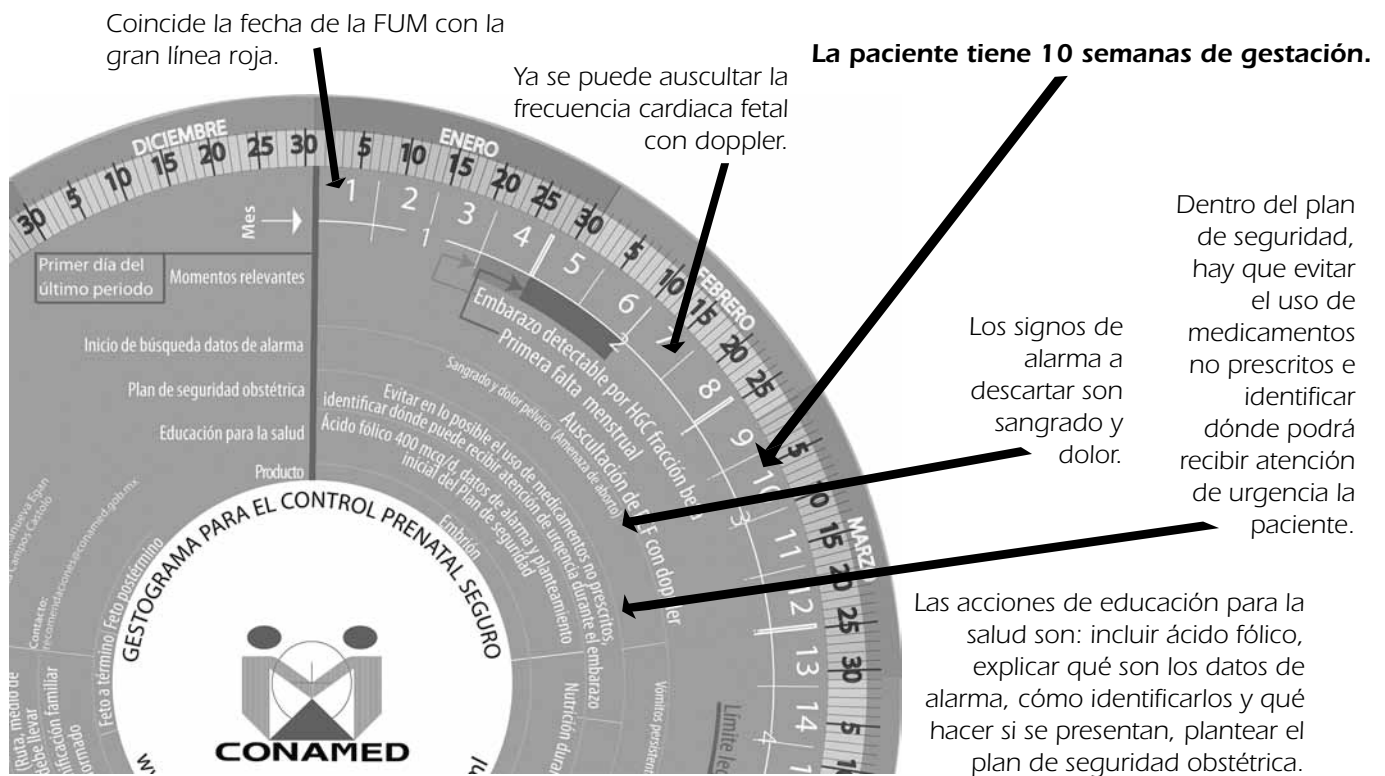
FUNDAMENTO TÉCNICO NORMATIVO

Este gestograma no es una revisión o compilación exhaustiva ni excluyente en cuanto al cuidado prenatal. Para conocer el

BIBLIOGRAFÍA

1. Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del Expediente Clínico. México: Diario Oficial de la Federación; 30-09-1999.
2. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. México: Diario Oficial de la Federación; 6-01-1995.

3. Guía de Práctica Clínica. Para el control prenatal con enfoque de riesgo. Evidencias y Recomendaciones. Catálogo Nacional de Guías de Práctica Clínica. México: CENETEC; 2008.
4. Guía Nacional de Práctica Clínica. Para el control prenatal con enfoque de riesgo. Guía de Referencia Rápida. México: Secretaría de Salud; 2008.
5. Freyermuth G, Meléndez D, Meneses G. Plan de Seguridad: un modelo de diseño y puesta en marcha de acciones para disminuir la muerte materna. Rev. Mujer y Salud (Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe). 2008; 4: 76-80.
6. Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva. Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México. México: Secretaría de Salud; 2008.
7. CLAP/OPS. El control prenatal. Salud Perinatal. 1990; 3(10): 121-136.
8. Aguilar MV, Muñoz SR, Velasco VJL, Cabezas GE, Ibargüen-goitia OF, Nuñez URM, Cerón MS. Control prenatal con enfoque de riesgo. Práctica Médica Efectiva. 2001; 3(9): 1-4.



ANEXO II

RECOMENDACIONES A LA MUJER EMBARAZADA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL DE SALUD DURANTE EL EMBARAZO, EL PARTO Y LA CUARENTENA (puerperio)

Lo sospechabas desde hace un tiempo. Hoy es una realidad confirmada. Estás felizmente embarazada. ¡Enhorabuena! Por favor lee con atención y responde las siguientes preguntas, muy importantes para toda futura madre:

¿Sabes qué es el control prenatal?

Si

No

¿Sabes qué hacer para solicitar atención y donde?

Si

No

¿Conoces los cuidados y estudios que requerirás durante tu embarazo

Si

No

Reconoces cuáles son los datos de alarma y que debes hacer si se presentan

Si

No

¿Ya elaboraste tu plan de seguridad para la embarazada

Si

No

TE INVITAMOS A LEER ESTA BREVE GUÍA, QUE TIENE LA INTENCIÓN DE MEJORAR TU COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL DE SALUD QUE TE ATENDERÁ DURANTE ESTOS MESES.

1 Los requisitos para solicitar atención durante el embarazo, el trabajo de parto y la cuarentena, pueden cambiar según cada institución.

- a) Acude o comunícate con la unidad médica para que averigües cuáles son los requisitos y si requieres darte de alta o entregar documentos adicionales.
- b) Lleva una identificación con foto.

- c) En instituciones de seguridad social y si eres beneficiaria del Seguro Popular, lleva tu credencial o documento que compruebe tu pertenencia al sistema.
- d) Conoce los servicios y costos que ofrecen las instituciones privadas, para que no haya sorpresas.

2 El Control Prenatal debe iniciar desde que te enteras que estás embarazada.

- a) El Control Prenatal de un embarazo normal en una mujer sana puede realizarlo un médico general, un enfermero perinatal o materno-infantil u otro personal de salud especialmente capacitado para este cuidado.
- b) El Control Prenatal de un embarazo con factores de riesgo especiales pero controlados, o con complicaciones ya resueltas, debe conducirlo un médico ginecoobstetra. En casos muy complejos, puede participar un perinatólogo o médico materno-fetal (sub-especialista dedicado a embarazos muy riesgosos).

3 Los FACTORES DE RIESGO son algunas características o enfermedades previas de la madre, así como problemas durante el embarazo, que aumentan la probabilidad de que la gestación se complique.

- a) Se califica un embarazo como de BAJO RIESGO si la embarazada es sana y no se han presentado complicaciones o éstas se han resuelto de manera satisfactoria.
- b) Los factores de riesgo más comunes durante el embarazo, son:
 - i) Edad menor a 15 años o mayor a 40 años
 - ii) Obesidad
 - iii) Factor sanguíneo RH negativo
 - iv) Enfermedades crónicas: presión alta (hipertensión), azúcar alta (diabetes), del corazón (cardiopatía), del riñón (nefropatía), etc.
 - v) Que haya tenido un parto, aborto u operación en la matriz (cirugía uterina) en los 18 meses previos 3 ó + partos, 2 ó + abortos; 2 ó + cesáreas
 - vi) Enfermedades o complicaciones desarrolladas en el embarazo actual: presión alta (hipertensión gestacional o preeclampsia), azúcar alta (diabetes gestacional), sangrados, líquido amniótico escaso o excesivo, bebé muy pequeño o muy grande para la edad gestacional, infecciones, alergias o cirugías durante el embarazo, etc.
 - vii) Factores socioculturales, como no hablar bien español y otros.
- c) Algunos factores de riesgo PUEDEN CAMBIAR en el transcurso del embarazo, si una complicación se resuelve o si se presentan nuevos problemas.

4 En caso de una urgencia (o emergencia) obstétrica real, cualquier institución, incluso privada, está obligada a dar atención a una paciente.

3

- a) Una urgencia médica es todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y requiera atención inmediata.
- b) Una emergencia obstétrica es un estado que pone en peligro la vida de la mujer durante el embarazo, parto y cuarentena, o también la vida del bebé. Requiere atención médica inmediata por personal calificado, en hospitales con la capacidad para resolver adecuadamente estos problemas.
- c) El Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas permite a las mujeres que presentan una emergencia durante el embarazo, el parto o la cuarentena, ser atendidas gratuitamente en la Secretaría de Salud, el IMSS o el ISSSTE, sin importar si son o no derechohabientes.
- d) Las instituciones privadas también están obligadas a atender a una mujer durante una emergencia obstétrica, sin embargo, los costos correspondientes deberán ser pagados por quien solicitó el servicio.

5 Existen cuidados y estudios mínimos que deben realizarse durante tu embarazo. Habrá algunos que serán específicos para tu caso en particular.

- a) La valoración habitual durante cada consulta incluye:
 - Identificación de DATOS DE ALARMA
 - Medición y registro de peso, presión arterial y cálculo de índice de masa corporal
 - Riesgo obstétrico
 - Crecimiento de la matriz (crecimiento uterino)
 - Cómo está el bebé (estado de salud del feto)
 - Molestias generales, alimentación, hábitos saludables
 - Revisión e interpretación de resultados de estudios solicitados.
- b) Los estudios de laboratorio que forman parte indispensable del Control Prenatal son: Biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, prueba VDRL, grupo sanguíneo y factor Rh y tamiz glucémico.
- c) Existen estudios, como el ultrasonido, que aunque son muy útiles y recomendables para valorar la evolución del embarazo, no son indispensables para un buen Control Prenatal.
- d) También es conveniente hacerse una prueba para detectar el VIH, especialmente en pacientes con factores de riesgo.
- e) Toda embarazada debe tomar hierro (sulfato o fumarato ferroso) y ácido fólico.

6 Los Datos de Alarma que indican que debes acudir de inmediato a revisión por un profesional de salud en un hospital son:

- Dolor de cabeza + zumbido de oídos + lucecitas o visión borrosa.
- Fiebre (calentura).
- Desmayos o ataques (convulsiones).
- Hinchazón de manos, cara o de todo el cuerpo.
- Náusea, vómito o dolor fuerte en la boca del estómago.
- Que el bebé se mueva menos o deje de moverse.
- Pancita dura con o sin dolor, dolores de parto (contracciones).
- Salida de sangre o líquido por la vagina.

NO TE AUTOMEDIQUES NI DEJES PASAR TIEMPO “A VER SI SE QUITA SOLO”, PUEDE SER PELIGROSO.

7 Toda embarazada debe elaborar, en conjunto con su familia y el profesional de la salud, un Plan de Seguridad para la Embarazada (Plan de Seguridad Obstétrica) para cada embarazo.

- a) El Plan de Seguridad de la Embarazada consiste en prever el nacimiento, considerando los siguientes puntos:
- Cuáles son los datos de alarma y qué hacer si se presentan, a quién llamar o a dónde acudir.
 - Dónde puede recibir atención de urgencia durante el embarazo.
 - Dónde se atenderá el nacimiento.
 - Fecha probable en que nacerá tu bebé.
 - Cómo llegar (ruta, medio de transporte).
 - Qué documentos y objetos debe llevar.
 - Qué método de prevención del embarazo (anticonceptivo) utilizarás.
 - Quiénes (familiares, amigos, compañeros de trabajo) y cómo participarán en el Plan de Seguridad.
 - Si ya tienes hijos, quién se hará cargo de ellos.

8 El embarazo normal no necesariamente debe durar 9 meses exactos.

- a) Los médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud que te atenderán, es probable que se refieran a tu embarazo en semanas, no en meses.
- b) El embarazo normal (A TÉRMINO) puede durar entre 37 y 41 semanas. Antes de las 37 semanas son PRETÉRMINO y después de las 41 semanas son POSTÉRMINO.

- c) Algunas veces, cuando tu menstruación no es exacta, el personal de salud puede usar otros datos o estudios, como el tamaño del bebé o un ultrasonido.

9 El trabajo de parto puede tardar hasta 48 horas, especialmente en las primerizas.

- a) La labor o trabajo de parto en una embarazada primeriza suele tardar entre 24 y 48 horas, a partir de que empieza el trabajo de parto verdadero.
- b) El trabajo de parto verdadero o efectivo, se presenta cuando hay de 3 a 4 contracciones en un lapso de 10 minutos (más o menos una contracción cada 2-3 minutos), duran entre 45 y 60 segundos y habitualmente producen dolor, que puede ser más intenso conforme pasan las horas.
- c) Cuando “se rompa la fuente” (ruptura de membranas corioamnióticas) debes acudir a revisión médica de inmediato, aunque el nacimiento del bebé puede tardar algunas horas.

10 Cuidados durante la cuarentena (puerperio)

- a) Siempre que sea posible, tú y tu bebé deberán estar juntos en el hospital para que lo alimentes con leche materna. Recuerda que la leche puede tardar en “bajar” hasta 72 horas y que al principio será escasa y transparente.
- b) Si aún no has decidido qué método anticonceptivo usarás, es el momento. Es conveniente esperar al menos 2 años para embarazarte de nuevo.
- c) Si te hicieron alguna incisión (cortadura en la piel), pregunta cómo debes cuidarla y si deberán retirarse los puntos de sutura.
- d) El sangrado transvaginal en la cuarentena (posparto o postcesárea) inicia rojo intenso y abundante como una regla. Conforme pasen los días, el sangrado se reduce y se diluye hasta desaparecer, dura aproximadamente 40 días.

ANEXO III

GUÍA DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA

Nacimiento

Fecha: _____ Hora: _____

Centro Hospitalario: _____

Vía de Nacimiento: Parto ☐ Cesárea ☐ Fórceps ☐

Peso: _____ Sexo: F ☐ M ☐

Talla: _____ APGAR: _____

Edad gestacional (CAPURRO): _____

Exploración Física R.N.: _____

Observaciones: _____

Registro nacimiento número: _____

Alojamiento conjunto: Sí ☐ No ☐

Método de planificación familiar: _____

Próxima cita: _____

Otros datos importantes: _____

ALARMA

Mamá, acude a urgencias si tienes:

Dolor de cabeza

Visión borrosa

Zumbido en oídos

Contracciones

Disminución de mis movimientos

Sangrado vaginal

Salida de líquido

Hinchazón de piernas o cara

**No olvides tu
guía en cada
visita al médico**

Doctor: Esta guía es un auxiliar
valioso para el seguimiento del
embarazo y la atención del parto.

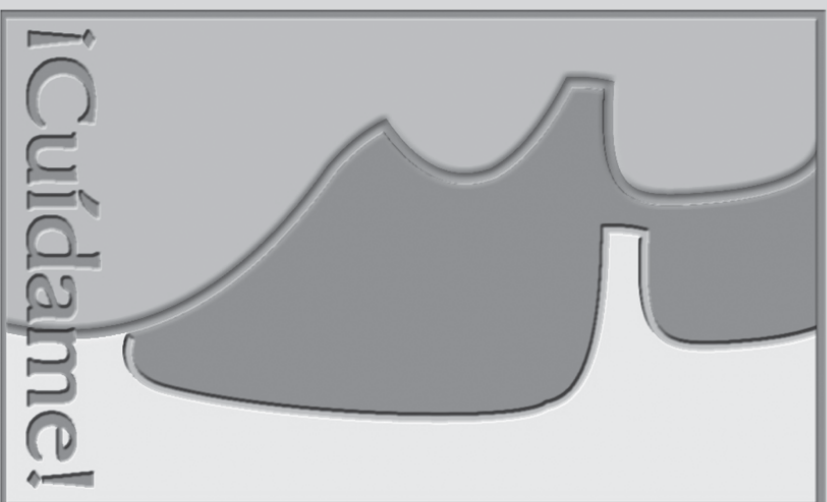
Utilízalo

No sustituye al expediente clínico
Sirve para apoyarte en la toma
de las mejores decisiones.



CONAMED

Guía de Información
Básica para la Atención
de la Mujer Embarazada



Nombre: _____

Antecedentes

U. Médica

Edad

FUM

Confiable

si

no

FPP

Grupo y Rh: Madre

Padre

Gestas

Partos

Cesáreas

Abortos

Ectópicos

Izq.

Der.

Talla

Peso antes del embarazo

Peso ideal

Hijos vivos

No.	Fecha nacimiento	Sem. gest. al nacim.	Peso	Vivo/Óbito/M.perinatal	Complicaciones	
					Madre	Hijo

Vigilancia del embarazo

Primer trimestre

Citas fecha	Sem. gest.	Peso	T/A	Fondo uterino	Signos y síntomas					Diagnóstico	Medicamento	Dosis
					Dolor obst.	Vómito	Urinaria	Vaginal	Edema			

Segundo trimestre

Signos y síntomas

Citas fecha	Sem. gest.	Peso	T/A	Fondo uterino	FCF	Dolor obst.	Mov. fetal	Urinaria	Vaginal	Edema	Diagnóstico	Medicamento	Dosis

Tercer trimestre

Signos y síntomas

Citas fecha	Sem. gest.	Peso	T/A	Fondo uterino	FCF	Activ.uterina	Mov. fetal	Urinaria	Vaginal	Edema	Diagnóstico	Medicamento	Dosis

Exámenes

VDRL

Tamíz de glucosa

Cervicovag

Fecha	Ht	Hb	Urea	Creatinina	Orina	Glu	Otros

Ultrasonografía

Embarazo: Único

Múltiple

1^{er} trim.

Fecha

Reporte

Fecha	DBP	L.F.	C.C.	C.A.	Local placentaria	Líqu. amniótico	Observaciones

Identificación de factores de riesgo

Fecha	Curso normal	Alto riesgo (anotar los factores de riesgo)	Manejo

REVERSO

Se terminó de imprimir en octubre de 2012 en los talleres de
Impresora y Encuadernadora Progreso, S. A de C. V. (IEPSA),
Calz. San Lorenzo 244, Col. Paraje de San Juan
09830, México, D. F.

Se tiraron 3,000 ejemplares

